



المجلد: (السابع عشر)
العدد: (التاسع والعشرون) يناير 2026م
-الجزء الثاني-

عدد خاص بالمؤتمر الدولي الواحد والعشرون

**International Journal of Educational and
Psychological Research and Studies**

**المجلة الدولية للبحوث
و الدراسات التربوية والنفسية
(IJRS).**

مجلة علمية دورية محكمة

**تصدرها الجمعية العربية لأصول التربية
والتعليم المستمر**

المشهرة برقم 6870 لسنة 2020

The Online ISSN : (2735-5063).
The print ISSN : (2735-5055).

بحث بعنوان:

دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي

لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا).

إعداد:

د. نعمات سعيد الزويكى.

أخصائي نفسي بمدرسة دسوق الثانوية العسكرية، إدارة دسوق.

محافظة كفر الشيخ، ومتبرعة دعم نفسي بمستشفى بهية (مصر).

مقدم:

المؤتمر الدولي الواحد والعشرون: تحت عنوان: (حقوق الآباء والأمهات والأبناء بين الرعاية

والإهمال من أجل أسرة عربية واعية وناضجة)، تحت شعار: (معاً لتوفير جو عائلي مليء

بالحب والعطف والطمأنينة).

المنعقد أيام (السبت - الاثنين) ١٧ - ١٩ جماد أول ١٤٤٧هـ، الموافق ٨ - ١٠ نوفمبر

٢٠٢٥م.

ملخص الدراسة.

هدف هذه الدراسة إلى: تحديد طبيعة وأبعاد الدعم النفسي الذي تقدمه مستشفى بهية للمصابات المتزوجات بسرطان الثدي، وقياس مستوى التكيف الاجتماعي لدى المريضات، والكشف عن طبيعة العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي.

وتحديد الفروق في مستوى التكيف الاجتماعي تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية (العمر، الحالة الاقتصادية، مدة الزواج)، وتقديم مقترحات علمية وتطبيقية لتطوير برامج الدعم النفسي بالمستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الثدي.

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بأسلوبه التحليلي، وكانت الاستبانة أداة لها، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أبرزها، ما يلي: أن الدعم النفسي يلعب دور في التكيف الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي، وأن زيادة تقديم جلسات الدعم النفسي يساعد في التكيف الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي.

وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على: (الدعم النفسي) ودرجاتهن على: (التكيف الاجتماعي). وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠٥) بين متوسطي درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) في اتجاه الأقل من ٣٥ سنة.

وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (التكيف الاجتماعي) في اتجاه: (الأقل من ٣٥ سنة). وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) وبعد: (التكيف الاجتماعي) في اتجاه المريضات ذوات مدة الإصابة: (أقل من ٣ سنوات).

وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) وبعد: (التكيف الاجتماعي) في اتجاه: (المريضات المشاركات في جلسات الدعم النفسي). وعدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي استجابات أفراد عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي وفقاً لمتغير نوع العلاج الحالي: (كيميائي - إشعاعي - جراحي).

الكلمات المفتاحية: (دور، الدعم النفسي، التكيف الاجتماعي، مواجهة تحديات سرطان الثدي، المتزوجات، مستشفى بهية نموذجًا).

Study Summary.

This study aimed to: identify the nature and dimensions of psychological support provided by Baheya Hospital to married women with breast cancer, measure the level of social adjustment among patients, and explore the relationship between psychological support and social adjustment.

Identifying differences in the level of social adjustment according to some demographic variables (age, economic status, duration of marriage), and providing scientific and applied proposals to develop psychological support programs in hospitals specializing in the treatment of breast cancer.

1441 The study used the descriptive approach with its analytical style, and the questionnaire was its tool. The study reached a number of results, the most prominent of which were the following: that psychological support plays a role in the social adjustment of breast cancer patients, and that increasing the provision of psychological support sessions helps in the social adjustment of breast cancer patients.

A statistically significant positive correlation ($p < 0.01$) was found between the scores of the breast cancer patients in the study sample on psychological support and their scores on social adjustment. A statistically significant difference ($p < 0.05$) was also found between the mean scores of the breast cancer patients in the study sample on psychological support, with those under 35 years of age scoring higher.

A statistically significant difference ($p < 0.01$) was found between the mean scores of the breast cancer patients in the study sample on the social adjustment dimension, favoring those under 35 years of age. A statistically significant difference ($p < 0.01$) was also found between the mean scores of the breast cancer patients in the study sample on the psychological support and social adjustment dimensions, favoring patients with a diagnosis duration of less than 3 years.

A statistically significant difference ($p < 0.01$) was found between the mean scores of the breast cancer patients in the study sample on the dimensions of psychological support and social adjustment, favoring patients who participated in psychological support sessions. However, no statistically

significant difference was found between the mean responses of the breast cancer patients in the study sample based on the type of treatment they were receiving: chemotherapy, radiotherapy, or surgery.

Keywords: (role, psychological support, social adaptation, facing the challenges of breast cancer, married women, Baheya Hospital as a model).

دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي

لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا).

مقدمة.

يُعدّ سرطان الثدي أحد أكثر الأمراض انتشارًا بين النساء في العالم عامة، وفي المجتمعات العربية على وجه الخصوص، وهو لا يمثل مجرد أزمة صحية فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح تحديًا نفسيًا واجتماعيًا يترك بصماته العميقة على حياة المرأة. فالإصابة بهذا المرض تُحدث هزة في بنية الذات الأنثوية، وتؤثر في علاقتها بذاتها وبآخرين، خاصة في الإطار الأسري والزوجي، لما يرافق المرض من تغييرات جسدية ونفسية واجتماعية.

وفي ظل هذا التحدي المركّب، يبرز الدعم النفسي كأحد المداخل الجوهرية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف الاجتماعي، من خلال مساعدتها على تجاوز مشاعر الخوف والقلق، واستعادة التوازن الداخلي، والانخراط مجددًا في الحياة الأسرية والمجتمعية بصورة إيجابية.

وتُعد مستشفى بهية نموذجًا مميزًا في هذا المجال، إذ تقدم خدمات متكاملة تجمع بين الرعاية الطبية والعلاج النفسي والاجتماعي، بما يجعلها نموذجًا تطبيقيًا صالحًا للدراسة العلمية التي تهدف إلى فهم الدور الذي يلعبه الدعم النفسي في تحسين جودة حياة المريضات، خصوصًا المتزوجات منهن اللواتي يتحملن مسؤوليات أسرية واجتماعية مضاعفة.

من هنا، تتبع أهمية هذه الدراسة في الكشف عن العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات المصابات بسرطان الثدي، انطلاقًا من واقع التجربة الإنسانية التي تحتضنها مستشفى بهية.

مشكلة الدراسة وتساؤلاتها.

تتمثل مشكلة الدراسة في السعي إلى التعرف على مدى إسهام الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى المتزوجات المصابات بسرطان الثدي، وذلك انطلاقًا من ملاحظة أن كثيرًا من المريضات يواجهن صعوبات نفسية واجتماعية بعد الإصابة، مما ينعكس على أدوارهن الأسرية وحياتهن الاجتماعية. ويتمثل السؤال الرئيس فيما يلي: ما دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى المتزوجات المصابات بسرطان الثدي في مستشفى بهية؟ ويتفرع عن هذه المشكلة الأسئلة الفرعية التالية:-

1) ما العلاقة الارتباطية بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان

الثدي؟

(2) هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا للعمر (أقل من ٣٥ سنة - ٣٥ سنة فأكثر)؟

(3) هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا مدة الإصابة (أقل من ٣ سنوات - ٣ سنوات فأكثر)؟

(4) هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا للمشاركة في جلسات الدعم (نعم - لا)؟

(5) هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا لنوع العلاج الحالي (كيميائي - إشعاعي - جراحي)؟

(6) ما دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات؟

أهداف الدراسة.

تهدف هذه الدراسة إلى:

(1) تحديد طبيعة وأبعاد الدعم النفسي الذي تقدمه مستشفى بهية للمصابات المتزوجات بسرطان الثدي.

(2) قياس مستوى التكيف الاجتماعي لدى المريضات.

(3) الكشف عن طبيعة العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي.

4) تحديد الفروق في مستوى التكيف الاجتماعي تبعًا لبعض المتغيرات الديموغرافية (العمر، الحالة الاقتصادية، مدة الزواج).

5) تقديم مقترحات علمية وتطبيقية لتطوير برامج الدعم النفسي بالمستشفيات المتخصصة في علاج سرطان الثدي.

أهمية الدراسة.

أولاً: الأهمية النظرية.

1) إثراء الأدبيات النفسية والاجتماعية حول العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى النساء المصابات بالأمراض المزمنة.

2) تقديم إطار نظري يوضح طبيعة التأثير المتبادل بين العوامل النفسية والاجتماعية في مواجهة المرض.

3) المساهمة في بناء قاعدة علمية يمكن الرجوع إليها في البحوث المستقبلية التي تتناول موضوعات مشابهة.

ثانياً: الأهمية التطبيقية.

1) إبراز الدور الريادي الذي تؤديه مستشفى بهية في مجال الدعم النفسي والاجتماعي للمريضات.

(2) الاستفادة من نتائج الدراسة في تصميم برامج نفسية واجتماعية تساعد المريضات على التكيف الإيجابي مع المرض.

(3) دعم صنّاع القرار في المؤسسات الصحية لتبني سياسات تعزز الرعاية الشاملة المتكاملة (الطبية والنفسية والاجتماعية).

حدود الدراسة.

(1) **الحدود المكانية:** تم تطبيق الدراسة في مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدي بمحافظة الجيزة، نظرًا لريادتها في مجال تقديم خدمات الدعم النفسي.

(2) **الحدود الزمانية:** تم إجراء الدراسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٥.

(3) **الحدود البشرية:** اقتصرت العينة على النساء المتزوجات المصابات بسرطان الثدي اللواتي يتلقين علاجًا داخل مستشفى بهية.

(4) **الحدود الموضوعية:** يقتصر موضوع الدراسة على التعرف على دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا).

مصطلحات الدراسة وتعريفاتها الإجرائية.

١. الدعم النفسي.

لغويًا: الدعم في اللغة مأخوذ من الفعل «دَعَمَ» أي قوَّى وسند وأعان، ويُقال: دعم الشيء أي شدَّ أركانه وثبَّته. أما «النفسي» فهو ما يتعلق بالنفس من مشاعر وأفكار وانفعالات (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤، ص ٤١٢).

وعليه، فـ«الدعم النفسي» لغويًا يعني المعاونة أو الإسناد الذي يُقدَّم للفرد من أجل تقوية حالته النفسية وتحسين توازنه الانفعالي.

اصطلاحًا: يُعرّف الدعم النفسي بأنه «مجموعة من الخدمات والإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الأفراد على التكيف مع المواقف الضاغطة، والتخفيف من معاناتهم الانفعالية، واستعادة شعورهم بالأمان والسيطرة على الذات» (الشريف، ٢٠١٩، ص ٢٢).

كما يراه Lazarus و Folkman (١٩٨٤، ص ٦٢) بأنه «الاستجابات السلوكية والانفعالية والمعرفية التي يقدمها الآخرون للفرد في المواقف الضاغطة، وتسهم في تحسين قدرته على المواجهة والصمود».

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، يُقصد بـ«الدعم النفسي» جميع الأنشطة والبرامج والخدمات التي تقدمها مستشفى بهية بهدف التخفيف من الضغوط النفسية للمريضات المتزوجات المصابات بسرطان الثدي، من خلال الإرشاد الفردي والجماعي، وجلسات الدعم، والتدريب على

استراتيجيات التكيف الإيجابي.

٢. التكيف الاجتماعي.

لغويًا: التكيف في اللغة من الفعل «كَيَّفَ» أي جعله على هيئة معينة، ويُقال: «تَكَيَّفَ الفرد مع بيئته» أي انسجم وتلاءم معها. أما «الاجتماعي»: فهو ما يتصل بالمجتمع وعلاقات الإنسان بالآخرين (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤، ص ٨٨٢).

وعليه، فإن «التكيف الاجتماعي» لغويًا: يعني قدرة الإنسان على التلاؤم مع متطلبات الحياة الاجتماعية وظروفها المتغيرة.

اصطلاحًا: يُعرَّف التكيف الاجتماعي بأنه «عملية مستمرة يسعى من خلالها الفرد إلى تحقيق التوازن بين ذاته وبيئته الاجتماعية، بما يضمن إشباع حاجاته بطريقة مقبولة اجتماعيًا» (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٤٥).

ويرى Schneiders (١٩٦٤، ص ١٢) أن: التكيف الاجتماعي هو: «مدى قدرة الفرد على إقامة علاقات مرضية مع الآخرين والقيام بأدواره الاجتماعية بطريقة تحقق له الشعور بالرضا والانتماء».

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، يُقصد بـ«التكيف الاجتماعي» مستوى قدرة المريضة المتزوجة المصابة بسرطان الثدي على الحفاظ على علاقاتها الأسرية والاجتماعية بصورة إيجابية، وممارسة أدوارها الزوجية والأمومية والاجتماعية رغم التحديات التي يفرضها المرض.

٣. سرطان الثدي.

لغويًا: السرطان في اللغة مشتق من لفظ «سرطان» أي الحيوان البحري المعروف، وقد أُطلق على هذا المرض لشبه امتداده وانتشاره بأرجل السرطان. أما «الثدي» فهو العضو الغدي في صدر المرأة المسؤول عن إفراز اللبن (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤، ص ٥٢٣).

اصطلاحًا: يُعرف سرطان الثدي بأنه «نمو غير طبيعي لخلايا أنسجة الثدي، تتميز بقدرتها على الانقسام غير المنضبط، وقد تنتشر إلى أنسجة أو أعضاء أخرى» (منظمة الصحة العالمية، ٢٠٢٣).

كما يعرفه American Cancer Society (٢٠٢٤) بأنه: «مرض يحدث عندما تبدأ بعض خلايا الثدي بالنمو بصورة غير طبيعية، مكونة ورمًا قد يكون حميدًا أو خبيثًا، ويعدّ من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين النساء على مستوى العالم».

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، يُقصد بـ«سرطان الثدي» الحالة المرضية التي تم تشخيصها طبيًا لدى المشاركات في مستشفى بهية، والمتابعة حاليًا للعلاج أو إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، بغض النظر عن مرحلة المرض.

٤. المتزوجات.

لغويًا: الزواج في اللغة من الفعل «زَوَّجَ» أي اقترن، وتزوَّج الرجل بالمرأة أي اتخذها زوجة، وهي علاقة تقوم على المودة والرحمة والعيش المشترك (ابن منظور، ٢٠٠٣، ص ٤١٢).

اصطلاحًا: تُعرّف المتزوجة بأنها: «المرأة التي تربطها علاقة زوجية رسمية برجل بموجب

عقد زواج شرعي، وتعيش معه حياة أسرية تقوم على المشاركة والمسؤولية» (القرني، ٢٠١٧،

ص ١٩).

التعريف الإجرائي: في هذه الدراسة، يُقصد بالمتزوجات النساء المصابات بسرطان الثدي

اللاتي لهنّ أزواج أحياء ويقمن معهم في إطار أسري فعلي، ويتلقين علاجًا نفسيًا أو اجتماعيًا

في مستشفى بهية.

٥. مستشفى بهية.

لغويًا: «بهية» اسم علم عربي يُستخدم للدلالة على الجمال والضياء، مأخوذ من الفعل

«بَهِيَ» أي أشرق وحسُن (مجمع اللغة العربية، ٢٠٠٤، ص ١١١).

اصطلاحًا: مستشفى بهية هي مؤسسة خيرية مصرية غير هادفة للربح، متخصصة في

الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان للسيدات، تأسست عام ٢٠١٥ بمنطقة الهرم -

الجيزة، وتُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط في تقديم خدمات طبية ونفسية متكاملة للمرأة

المصرية (موقع مستشفى بهية الرسمي، ٢٠٢٥).

التعريف الإجرائي: في سياق هذه الدراسة، يُقصد بـ«مستشفى بهية» المؤسسة الصحية

محل الدراسة الميدانية، التي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ونفسية متكاملة للنساء المتزوجات

المصابات بسرطان الثدي، وتشمل برامج الدعم النفسي والاجتماعي موضوع الدراسة.

الدراسات السابقة.

نظرًا لما يمثله الدعم النفسي والاجتماعي من أهمية محورية في حياة المريضات المصابات بسرطان الثدي، فقد حظي هذا المجال باهتمام متزايد من الباحثين في العلوم النفسية والاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، إذ تناولت العديد من الدراسات العربية العلاقة بين الدعم النفسي والاجتماعي والتكيف وجودة الحياة لدى مريضات السرطان، وسعت إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في هذا التكيف، ومصادر الدعم الأكثر فاعلية في التخفيف من الآثار الانفعالية والاجتماعية للمرض.

وتتسم هذه الدراسات بتنوع مناهجها بين الوصفي والتحليلي وشبه التجريبي، كما اختلفت في عيناتها بين المريضات المتزوجات وغير المتزوجات، وفي البيئات العلاجية التي أجريت فيها. واستنادًا إلى مراجعة دقيقة لما توفر من بحوث أكاديمية منشورة، تم اختيار مجموعة من الدراسات ذات الصلة المباشرة بموضوع البحث الحالي، لتُمثل الإطار المرجعي والمعرفي الذي يُبنى عليه هذا العمل العلمي.

- 1) خالد (٢٠٢٥) بعنوان: الدعم الاجتماعي المُدرك وتحسين جودة الحياة: بحث ميداني على عينة من مريضات سرطان الثدي. هدفت الدراسة إلى: التعرف على أبعاد الدعم الاجتماعي المُدرك وتأثيره على تحسين جودة الحياة لدى مريضات سرطان الثدي، من خلال تطبيق ميداني على عينة من (٩٨) مريضة في مستشفى القوات المسلحة ومركز أورام بني سويف الجامعي.

واستخدمت الدراسة المنهج: الوصفي التحليلي، بالاعتماد على أداة الاستبيان التي تضمنت ثلاثة محاور (بيانات عامة - مقياس الدعم الاجتماعي - مقياس جودة الحياة). وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن مستوى الدعم الاجتماعي المُدرك كان مرتفعًا لدى المريضات، وأن أكثر مصادر الدعم تأثيرًا هو دعم الفريق الطبي يليه دعم الأسرة ثم دعم الأصدقاء والأقارب. كما تبين وجود علاقة ارتباطية موجبة ذات دلالة إحصائية بين الدعم الاجتماعي المُدرك وجودة الحياة.

(2) الزهراني (٢٠٢٣) بعنوان: الكرب النفسي والدعم الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي في ضوء بعض المتغيرات. هدفت الدراسة إلى: الكشف عن مستوى الكرب النفسي والدعم الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي، والتعرف على الفروق باختلاف المتغيرات الديموغرافية (العمر، الحالة الاجتماعية، المرحلة التعليمية، مرحلة العلاج، مدة الإصابة).

واستخدمت الدراسة المنهج: الوصفي التحليلي، وطبقت على عينة من (١٦٣) مريضة تتلقى العلاج في قسم الأورام بمدينة الملك فهد الطبية ومستشفى قوى الأمن بالرياض. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: وجود علاقة ارتباطية عكسية دالة إحصائيًا بين الكرب النفسي ومستوى الدعم الاجتماعي، بحيث يؤدي ارتفاع الدعم الاجتماعي إلى انخفاض درجة الكرب النفسي. كما تبين أن الحالة الاجتماعية (الزواج) من العوامل المؤثرة في مستوى الدعم النفسي والاجتماعي.

(3) أشتية (٢٠١٨) بعنوان: تأثير المساندة الاجتماعية في الصلابة النفسية لدى

المصابين بمرض السرطان. هدفت الدراسة إلى: قياس العلاقة بين المساندة الاجتماعية

والصلابة النفسية لدى المصابين بالسرطان في جامعة القدس المفتوحة. واستخدمت

الدراسة المنهج: الوصفي الارتباطي، وشملت عينة من (١٢٠) مريضًا ومريضة.

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: وجود علاقة موجبة ذات دلالة إحصائية

بين المساندة الاجتماعية ومستوى الصلابة النفسية، وأن المساندة الأسرية تلعب الدور الأكبر في

تحقيق التوازن النفسي والتكيف مع المرض.

(4) الحبشي (٢٠٢٠) بعنوان: الدعم الاجتماعي الأسري لدى مريضات سرطان الثدي

وعلاقته بجودة الحياة النفسية. هدفت الدراسة إلى: التعرف على أثر الدعم الأسري

في تحسين جودة الحياة النفسية والاجتماعية لدى مريضات سرطان الثدي بمدينة تعز. 1441

واستخدمت الدراسة المنهج: الوصفي التحليلي على عينة مكونة من (٨٠) مريضة. وتوصلت

الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن وجود شبكة دعم أسري قوية يخفف من حدة الاكتئاب

والقلق، ويساعد المريضات على التكيف مع العلاج ومراحله المختلفة.

(5) العنزي (٢٠٢٣) بعنوان: جودة الحياة وأنواع الدعم الاجتماعي والأبعاد المفسرة

لها لدى مريضات السرطان. هدفت الدراسة إلى: تحديد نوع الدعم الاجتماعي الأكثر

تأثيرًا في جودة الحياة لدى مريضات السرطان، مع تحليل العوامل الاجتماعية والنفسية المفسرة لذلك.

واستخدمت الدراسة المنهج: التحليلي المقارن على عينة من (١٣٠) مريضة في مستشفيات الكويت. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن الدعم الاجتماعي من الأصدقاء والفريق الطبي يسهم بدرجة كبيرة في تحسين جودة الحياة مقارنة بالدعم المادي.

(6) تومي (٢٠١٧) بعنوان: جودة الحياة الأسرية والدعم الاجتماعي المُدرك لدى مرضى السرطان من منظور علم النفس الإيجابي. هدفت الدراسة إلى: بحث العلاقة بين جودة الحياة الأسرية ومستوى الدعم الاجتماعي المُدرك لدى مرضى السرطان في الجزائر.

واستخدمت الدراسة المنهج: الوصفي التحليلي، وطبقت على (١٥٠) مريضًا ومريضة بمركز مكافحة السرطان في باتنة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي يساهم في تعزيز الرضا عن الحياة وتقليل الشعور بالوحدة.

(7) بوتى (٢٠٢٠) بعنوان: رؤية نظرية في جودة الحياة والتنمية المستدامة: الأبعاد والتحديات. هدفت الدراسة إلى: استعراض المفهوم النظري لجودة الحياة وعلاقتها بالتنمية المستدامة من منظور نفسي واجتماعي.

واستخدمت الدراسة المنهج: النظري التحليلي من خلال مراجعة الأدبيات السابقة. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها: أن جودة الحياة لا تتفصل عن الدعم النفسي والاجتماعي، وأن إدماج برامج الدعم ضمن الخدمات الصحية يسهم في تحسين التكيف مع الأمراض المزمنة. التعليق والاستنتاج.

أولاً: أبرز النتائج المستخلصة من الدراسات السابقة.

أظهرت الدراسات السابقة جميعها- على اختلاف عيناتها وبيئاتها البحثية- اتفاقاً جوهرياً على أن الدعم النفسي والاجتماعي يشكل عنصراً حاسماً في عملية التكيف مع مرض سرطان الثدي، سواء كان الدعم صادراً عن الأسرة، أو الأصدقاء، أو الطاقم الطبي، أو حتى عن الجماعات المساندة.

وأوضحت نتائج دراسة خالد (٢٠٢٥) أن الدعم الاجتماعي المُدرَك يرفع من جودة الحياة النفسية والجسدية للمريضات، إذ تبين أن أكثر مصادر الدعم تأثيراً هو دعم الفريق الطبي ثم دعم الأسرة. بينما أكدت دراسة الزهراني (٢٠٢٣) على أن الكرب النفسي ينخفض طردياً بارتفاع الدعم الاجتماعي، ما يعني أن الدعم يمثل آلية وقائية من الانهيار النفسي والانفعال الزائد.

أما دراسة العنزي (٢٠٢٣) فأضافت بعداً تحليلياً جديداً، حين كشفت أن نوعية الدعم الاجتماعي (عاطفي، مادي، معرفي) تختلف في أثرها على جودة الحياة؛ حيث احتل الدعم المعنوي والعاطفي المرتبة الأولى. وتقاطعت تلك النتيجة مع دراسة الحبشي (٢٠٢٠) التي أثبتت

أن الدعم الأسري هو أقوى مؤشرات الاستقرار النفسي للمريضات، لأنه يُشعر المرأة بأنها ما تزال محاطة بالحب والقبول، على الرغم من التغيرات الجسدية والنفسية التي يسببها المرض.

كما دعمت دراسة أشتية (٢٠١٨) الفرضية القائلة إن المساندة الاجتماعية تعزز الصلابة النفسية، مؤكدة أن الشبكات الاجتماعية الداعمة (الأسرة والأصدقاء والمجتمع) تقلل الشعور بالوحدة وتزيد من المرونة في مواجهة المرض. ومن منظور نفسي إيجابي، خلصت دراسة تومي (٢٠١٧) إلى أن الدعم الاجتماعي يرتبط بارتفاع الرضا عن الحياة وبانخفاض مستويات الاكتئاب والعزلة، مشيرة إلى ضرورة دمج الدعم الأسري ضمن الخطط العلاجية.

من جهة أخرى، أبرزت دراسة بوتى (٢٠٢٠) البعد النظري لمفهوم جودة الحياة باعتباره منظومة متكاملة تتأثر بعوامل نفسية واجتماعية واقتصادية، مؤكدة أن الدعم النفسي والاجتماعي أحد أعمدة التنمية الإنسانية المستدامة.

وبذلك يمكن القول إن الدراسات السابقة مجتمعة توصلت إلى إجماع علمي واضح بأن الدعم النفسي والاجتماعي يساهم في تمكين المريضات من تحقيق التكيف الاجتماعي، ويمنحهن القدرة على إعادة بناء أدوارهن الأسرية والاجتماعية بعد الصدمة المرضية.

ثانيًا: أوجه الشبه والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة.

أوجه الشبه.

- تتقاطع الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في اتفاقها على أهمية الدعم النفسي والاجتماعي كمتغير تفسيري للتكيف وجودة الحياة.
- مثلها مثل دراسة خالد (٢٠٢٥) والعنزي (٢٠٢٣)، تعتمد الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي وأساليب القياس الميداني عبر استبيانات مقننة.
- جميع الدراسات السابقة - باستثناء بوتي (٢٠٢٠) - استهدفت عينات من النساء المريضات بالسرطان، مما يعزز اتساق التوجه البحثي نحو البعد النفسي للمرض.
- تتفق جميع الدراسات على أن الدعم الأسري والزوجي يمثل العامل الأكثر تأثيرًا في التكيف الإيجابي، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى توثيقه ميدانيًا في سياق مستشفى بهية.

أوجه الاختلاف.

- 1) الدراسة الحالية تتميز بأنها تركّز على فئة المتزوجات تحديدًا، وهو بعد لم تتناوله الدراسات السابقة بشكل تفصيلي رغم أهميته النفسية والاجتماعية؛ فالمتزوجة تواجه تحديات مزدوجة تتعلق بدورها كزوجة وأم ومريضة في آن واحد.

(2) تتفرد الدراسة الحالية بكونها تطبق على نموذج مؤسسي محدد هو مستشفى بهية، الذي

يمثل بيئة علاجية مصرية متكاملة تقدم خدمات نفسية وطبية مجانية، وهو ما يجعلها

نموذجًا فريدًا للمقارنة مع مؤسسات أخرى.

(3) كما تتميز بأنها تمزج بين مفهومي الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي ضمن إطار

واحد، بينما ركزت أغلب الدراسات السابقة على أحد المتغيرين فقط (إما الدعم أو

التكيف).

(4) الدراسة الحالية تتبنى منظورًا تطبيقيًا مجتمعيًا يستهدف ربط نتائجها بتوصيات عملية

لتطوير برامج الدعم داخل المؤسسات الصحية.

ثالثًا: الثغرات البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى سدها.

2019 على الرغم من غنى الميدان البحثي بالدراسات السابقة، إلا أنه ما زالت هناك ثغرات

علمية ومعرفية تسعى الدراسة الحالية إلى سدها: -

1. غياب تناول المتكامل للدعم النفسي والاجتماعي في السياق الزوجي: أغلب

الدراسات ركزت على الدعم بشكل عام دون تفكيك العلاقة بين الزواج كمصدر دعم

مباشر وتأثيره في التكيف الاجتماعي، وهو ما تسعى الدراسة الحالية إلى تحليله

تفصيلًا.

2. ندرة الدراسات التطبيقية على مستشفيات خيرية مصرية: معظم البحوث السابقة

جرت في مستشفيات حكومية أو جامعية، بينما مستشفى بهية تمثل نموذجًا فريدًا في

الدمج بين العلاج الطبي والدعم النفسي المجاني للمرأة، مما يجعل هذه الدراسة الأولى

من نوعها في هذا الإطار.

3. ضعف الدراسات المقارنة بين أبعاد الدعم النفسي المختلفة (العاطفي، المعرفي،

السلوكي): تركز هذه الدراسة على تحليل كل بعد من أبعاد الدعم النفسي في علاقته

بمستويات التكيف الاجتماعي، لتقديم تصور أكثر دقة وتفصيلاً للعمليات النفسية

المساندة.

4. الحاجة إلى نموذج تفسيري متكامل: تفتقر الدراسات السابقة إلى نموذج مفاهيمي

يجمع بين المتغيرات النفسية والاجتماعية والزوجية في تفسير التكيف. تهدف الدراسة

الحالية إلى صياغة نموذج إجرائي يمكن استخدامه في بناء برامج الدعم النفسي

المستقبلية.

5. ضعف التركيز على الجانب الثقافي العربي في سياق التكيف مع المرض: فغالبية

النماذج المستخدمة مستوردة من بيئات غربية. لذلك، تُسهم هذه الدراسة في إعادة

توطين المفاهيم النفسية والاجتماعية ضمن الثقافة المصرية والعربية، بما يعزز موثوقية

النتائج وإمكانية تطبيقها محليًا.

الإطار النظري.

يُعد الإطار النظري الركيزة الأساسية التي يقوم عليها هذا البحث، إذ يُقدّم الأسس المفاهيمية والفكرية التي تُفسّر العلاقة بين متغيري الدراسة: الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات المصابات بسرطان الثدي.

ويستند هذا الإطار إلى ما ورد في الأدبيات النفسية والاجتماعية من مفاهيم ونظريات ودراسات سابقة توضّح طبيعة هذه المتغيرات وأبعادها وعلاقاتها المتبادلة، كما يُسهم في بناء تصور علمي متكامل يساعد على تفسير النتائج الميدانية في ضوء خلفية نظرية راسخة. ومن ثمّ، يتضمن هذا الإطار ثلاثة مباحث رئيسة تتناول المفاهيم الأساسية لمتغيرات الدراسة والعلاقات التفاعلية فيما بينها.

المبحث الأول: الدعم النفسي.

أولاً: أنواع الدعم النفسي.

تنوّعت تصنيفات الدعم النفسي في الأدبيات النفسية تبعاً لطبيعة العلاقة بين الفرد ومصادر الدعم. وقد اتفقت معظم الدراسات الحديثة على أن الدعم النفسي لا يقتصر على بُعد واحد، بل هو منظومة متكاملة من التفاعلات الانفعالية والاجتماعية والمعرفية التي تهدف إلى مساعدة الفرد في مواجهة الضغوط وتحقيق التكيف (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٤٥). ويمكن تصنيف الدعم النفسي إلى أربعة أنواع رئيسة:

1. الدعم العاطفي (Emotional Support).

يشير الدعم العاطفي إلى المساندة الوجدانية التي تُقدّم للفرد في أوقات الشدة، وتشمل مشاعر التعاطف، والاهتمام، والقبول، والحنان، مما يُشعره بالأمان والطمأنينة. وقد أكدت دراسات متعددة أن الدعم العاطفي من أكثر أشكال الدعم تأثيرًا في الحد من التوتر النفسي للمريضات المصابات بالسرطان (تومي، ٢٠١٧، ص ١٢٥).

ويُعد الدعم العاطفي الذي يُقدّمه الزوج والأسرة المحيط المباشر بالمريضة أحد أبرز عوامل التوازن النفسي، إذ يساهم في تخفيف الشعور بالعزلة وفقدان القيمة الذاتية، ويدعم الدافعية نحو التكيف والاستمرار في العلاج (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩٢).

2. الدعم المعرفي (Cognitive Support).

يقصد بالدعم المعرفي تزويد الفرد بالمعلومات الصحيحة والمفاهيم الواقعية التي تساعد على فهم حالته المرضية والتعامل معها بشكل إيجابي. ويشمل هذا النوع من الدعم الإرشاد النفسي والتثقيف الصحي الذي تُقدّمه المؤسسات الطبية أو الأخصائيون النفسيون (بوتي، ٢٠٢٠، ص ١٨). فكلما ازدادت معرفة المريضة بطبيعة المرض وخطوات العلاج، ارتفعت قدرتها على السيطرة الإدراكية والانفعالية، ما ينعكس إيجابًا على استقرارها النفسي والاجتماعي (خالد، ٢٠٢٥، ص ٦٠).

3. الدعم السلوكي (Behavioral Support).

يُقصد بالدعم السلوكي المساعدة العملية التي تُقدّم للمريض من خلال الأفعال والسلوكيات المساندة، مثل المساعدة في الذهاب إلى المستشفى أو تنظيم مواعيد العلاج أو توفير الاحتياجات اليومية. ويُعتبر هذا النوع من الدعم ترجمة فعلية للتعاطف والمساندة، إذ يُشعر المريضة بأنها ليست وحدها في مواجهة التحدي (أشتية، ٢٠١٨، ص ٧٠). كما يرتبط الدعم السلوكي بزيادة التزام المريضات بالبرنامج العلاجي، لأنه يُخفف من الأعباء اليومية التي تُسبب الإجهاد النفسي والجسدي (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٣٨).

4. الدعم الاجتماعي (Social Support).

يتمثل الدعم الاجتماعي في شبكات العلاقات التي تحيط بالفرد، سواء داخل الأسرة أو بين الأصدقاء أو في المجتمع الأوسع، والتي تُمكنه من الشعور بالانتماء والتقدير. وقد أكدت الدراسات أن الدعم الاجتماعي بمختلف مستوياته يساهم في تعزيز الشعور بالأمان والاندماج الاجتماعي، ويقلل من احتمالية الإصابة بالاكتئاب أو العزلة (الزهراني، ٢٠٢٣، ص ٣٣٠). ويُعدّ الدعم الاجتماعي حجر الزاوية في برامج الرعاية النفسية للمريضات بسرطان الثدي، لأنه يوفر بيئة حاضنة تُمكن المريضة من استعادة ثقها بذاتها وممارسة أدوارها الاجتماعية بعد المرض.

ثانيًا: أهمية الدعم النفسي لمرضى السرطان.

1. دوره في التخفيف من القلق والاكتئاب.

أشارت الدراسات إلى أن الإصابة بالسرطان ترتبط غالبًا بارتفاع مستويات القلق والاكتئاب بسبب الخوف من الألم أو فقدان الأمل في الشفاء. وهنا يبرز دور الدعم النفسي كعامل وقائي يقلل من شدة الاضطرابات الانفعالية. فقد أوضحت دراسة العنزي (٢٠٢٣، ص ٣٣) أن المريضات اللواتي تلقين دعمًا نفسيًا منتظمًا أظهرن درجات أقل من الاكتئاب والقلق مقارنة بغيرهن. كما بيّنت دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٧٥) أن ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي المُدرك يخفف من أعراض التوتر، ويُسهم في تحسين المزاج العام وجودة النوم والقدرة على مواجهة الألم.

2. أثره في تعزيز الثقة والقدرة على المواجهة.

يُعد الدعم النفسي وسيلة فعالة لبناء الثقة بالنفس والقدرة على المواجهة الإيجابية، إذ يمنح المريضة الإحساس بالقدرة على التحكم في مجريات حياتها، ويُشجعها على التكيف مع التغيرات الجسدية والنفسية التي يفرضها المرض. وتؤكد دراسة الحبشي (٢٠٢٠، ص ٩٧) أن المساندة العاطفية المنتظمة تُعيد للمريضة الشعور بالكرامة والقبول الذاتي، مما يرفع مستوى التوافق الزوجي والاجتماعي لديها. كذلك أظهرت دراسة أشتية (٢٠١٨، ص ٧٢) أن الدعم النفسي يعزز الصلابة النفسية ويُنمّي المرونة الانفعالية في مواجهة الضغوط.

3. العلاقة بين الدعم النفسي والتحفيز على الالتزام بالعلاج.

يُعتبر الدعم النفسي محفزًا أساسيًا للالتزام بالعلاج، إذ يساهم في رفع الروح المعنوية ويُشجع المريضة على متابعة الجلسات العلاجية دون انقطاع. ووفقًا لدراسة الزهراني (٢٠٢٣، ص ٣٤٨)، ترتبط معدلات الالتزام بالعلاج طرديًا مع مستوى الدعم الاجتماعي والأسري، حيث إن المريضات اللاتي يحصلن على دعم مستمر يُظهرن قدرة أكبر على المثابرة والالتزام بالمواعيد العلاجية. ومن هذا المنطلق، يصبح الدعم النفسي جزءًا لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية المتكاملة، وليس مجرد نشاط تكميلي.

ثالثًا: الدعم النفسي في مستشفى بهية كنموذج تطبيقي.

1. طبيعة البرامج النفسية في مستشفى بهية.

تُعد مستشفى بهية من أوائل المؤسسات المصرية التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالدعم النفسي إلى جانب العلاج الطبي. إذ تشتمل برامجها على جلسات إرشاد نفسي فردي وجماعي، وبرامج تأهيل معرفي وانفعالي موجهة للمريضات وأسرهن. كما تُنظّم ورش عمل ودورات توعوية لتعريف المريضات بآليات التكيف النفسي والتمسك بالأمل خلال مراحل العلاج (موقع مستشفى بهية، ٢٠٢٥، ص ٢). وتُعد هذه البرامج جزءًا أصيلًا من الخطة العلاجية داخل المستشفى، مما يعكس وعيًا مؤسسيًا بأهمية الصحة النفسية في نجاح العلاج الجسدي.

٢. دور الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين.

يلعب الأخصائي النفسي والاجتماعي في مستشفى بهية دورًا محوريًا في رصد الحالة النفسية للمريضة منذ التشخيص الأول وحتى نهاية العلاج. حيث تُجرى مقابلات تقييم مبدئية لتحديد احتياجات المريضة النفسية والاجتماعية، يليها تقديم جلسات دعم موجهة تراعي الفروق الفردية.

كما يتم إشراك الأسرة في بعض الجلسات لتعزيز الدعم الأسري (خالد، ٢٠٢٥، ص ٩٢). ويعمل الفريق النفسي جنبًا إلى جنب مع الأطباء والممرضين لتقديم نموذج رعاية تكاملية يجمع بين البعد العلاجي والإنساني.

٣. الأنشطة والجلسات الموجهة للمتزوجات.

تولي مستشفى بهية اهتمامًا خاصًا بالمريضات المتزوجات نظرًا لما يواجهنه من تحديات مزدوجة، نفسية وزوجية واجتماعية. وتشمل الأنشطة الموجهة لهن جلسات حوارية حول التكيف مع التغيرات الجسدية بعد الجراحة، والتواصل مع الزوج، وإدارة المشاعر السلبية المرتبطة بالمرض. كما تُعقد لقاءات جماعية تجمع المريضات لتبادل الخبرات والدعم المعنوي (موقع مستشفى بهية، ٢٠٢٥، ص ٣). هذه الجلسات تسهم في بناء مجتمع مساند داخل المستشفى، يعزز روح الانتماء ويخفف من الشعور بالوصمة أو العزلة.

المبحث الثاني: التكيف الاجتماعي.

أولاً: مفهوم التكيف الاجتماعي وأبعاده.

يُعدّ مفهوم التكيف الاجتماعي من المفاهيم الجوهرية في ميدان علم النفس الاجتماعي، إذ يُمثل العملية التي من خلالها يسعى الفرد إلى تحقيق التوازن بين ذاته وبيئته الاجتماعية بما يضمن له الشعور بالرضا، والقبول، والقدرة على أداء أدواره المختلفة بكفاءة.

وقد حظي هذا المفهوم باهتمام كبير في الأدبيات النفسية، نظرًا لارتباطه الوثيق بالصحة النفسية وجودة الحياة، ولا سيّما لدى الأفراد الذين يواجهون مواقف حياتية ضاغطة مثل المرض المزمن أو السرطان (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٤٦). يشير **Folkman و Lazarus (١٩٨٤)**، (ص ٦٢) إلى أن: التكيف هو «العملية الدينامية التي يسعى من خلالها الفرد إلى إدارة المطالب الخارجية أو الداخلية التي تُختبر بأنها تفوق قدراته أو موارده».

أما **Schneiders (١٩٦٤، ص ١٢)** فقد عرّفه بأنه: «القدرة على إقامة علاقات مرضية مع الآخرين والقيام بالأدوار الاجتماعية بطريقة تحقق للفرد الشعور بالانتماء والقبول»، وفي السياق العربي، يعرّف عبد الله (٢٠١٩، ص ٨١) التكيف الاجتماعي بأنه: «القدرة على التفاعل الإيجابي مع متغيرات البيئة الاجتماعية في ضوء معايير وقيم المجتمع، بما يسمح للفرد بالقيام بوظائفه الاجتماعية دون اضطراب».

وبناءً على ما تقدّم، يمكن القول إن: التكيف الاجتماعي هو عملية مستمرة تهدف إلى تحقيق الانسجام بين الفرد والمجتمع، بحيث يتمكن الفرد من مواجهة الصعوبات والأزمات دون أن يفقد توازنه النفسي أو قدرته على التفاعل مع الآخرين.

وفي حالة مرضى السرطان، يصبح هذا التكيف أكثر تعقيداً، لأنه لا يقتصر على التعامل مع الألم الجسدي فحسب، بل يمتد إلى التكيف مع فقدان بعض الأدوار الاجتماعية والوظيفية، ومع نظرة المجتمع أو الأسرة للمريض (تومي، ٢٠١٧، ص ١٢٧).

أبعاد التكيف الاجتماعي.

يتضمن التكيف الاجتماعي مجموعة من الأبعاد المتداخلة التي تُعبّر عن الجوانب النفسية والسلوكية والاجتماعية التي تُمكن الفرد من العيش بتوازن وانسجام مع محيطه. ويمكن تلخيص أهم هذه الأبعاد كما يلي:-

١. البعد الأسري.

يُعدّ الأسرة أول وأهم بيئة اجتماعية يتعلّم فيها الفرد أنماط السلوك والتفاعل مع الآخرين. ويُقاس التكيف الأسري بمدى قدرة الفرد على أداء دوره داخل الأسرة دون صراعات أو اضطرابات حادة (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩١).

وفي حالة النساء المصابات بسرطان الثدي، يبرز البعد الأسري كمحور أساسي، إذ تواجه المريضة تغيرات في الأدوار والمسؤوليات الأسرية، وقد تشعر بالعجز أو التقصير تجاه الأبناء أو الزوج. وهنا يظهر الدور الحيوي للأسرة في تقديم الدعم النفسي والعاطفي اللازم لتحقيق التكيف الأسري الإيجابي.

وقد بينت دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٧٨) أن الزوج يمثل مصدر دعم نفسي مهم يسهم في تعزيز التقبل الذاتي لدى المريضة، ويقلل من حدة الانسحاب الأسري أو الشعور بالوصمة. كما أن تفهم الأسرة لاحتياجات المريضة يزيد من إحساسها بالانتماء ويحد من النزعات الانعزالية.

٢. البعد الاجتماعي العام.

يشير هذا البعد إلى قدرة الفرد على تكوين علاقات اجتماعية سوية مع الآخرين والمشاركة في الأنشطة المجتمعية دون خوف أو عزلة. ويُعتبر هذا الجانب من أكثر مظاهر التكيف تأثرًا عند المريضات بالسرطان، إذ قد يؤدي المرض إلى تقليص نطاق العلاقات الاجتماعية أو الانسحاب من التفاعلات اليومية (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٣٩).

وتؤكد دراسات عديدة أن وجود شبكات اجتماعية مساندة - سواء من الأصدقاء أو الزملاء أو المجموعات المجتمعية - يساعد المريضة على الحفاظ على إحساسها بالهوية الاجتماعية ويخفف من الشعور بالنبذ أو الضعف (الزهراني، ٢٠٢٣، ص ٣٣٧).

كما يرتبط هذا البعد ارتباطاً وثيقاً بمدى قدرة المجتمع على تقبل المريضات نفسياً واجتماعياً.

فكلما زادت الثقافة المجتمعية الداعمة لمرضى السرطان، سهلت عملية التكيف الاجتماعي وخفت وطأة العزلة والانغلاق النفسي.

٣. البعد النفسي - الانفعالي.

يتعلق هذا البعد بالاستقرار الداخلي والقدرة على ضبط الانفعالات والتعبير عنها بطريقة متوازنة. فالتكيف النفسي شرط أساسي لتحقيق التكيف الاجتماعي؛ إذ لا يمكن للفرد أن يندمج في المجتمع إذا كان يعاني من اضطراب نفسي حاد أو فقدان للثقة في الذات (أشتية، ٢٠١٨، ص ٧٣).

وفي حالة المريضات المصابات بسرطان الثدي، يُعد هذا البعد من أكثر الجوانب هشاشة نظراً لتأثير المرض على الصورة الذاتية للمرأة، وعلى إحساسها بجمالها ودورها الاجتماعي. ومن ثم، فإن تحقيق التكيف النفسي يُعدّ مدخلاً رئيساً لإعادة بناء العلاقات الاجتماعية. وقد أوضحت دراسة تومي (٢٠١٧، ص ١٣٠) أن الدعم النفسي المستمر يرفع من مستوى الرضا عن الحياة، ويعزز الثقة بالنفس، مما يؤدي إلى تحسين العلاقات الاجتماعية وتوازنها.

٤. البعد المهني والاجتماعي الإنتاجي.

يرتبط هذا البعد بقدرة الفرد على التكيف في بيئة العمل أو الدراسة أو الإنتاج، بما يعكس

استمرار دوره الإيجابي في المجتمع. إذ إن فقدان الوظيفة أو الانقطاع عن النشاط المهني بسبب

المرض قد يؤدي إلى فقدان جزء من الهوية الاجتماعية، ومن ثمّ انخفاض مستوى التكيف العام (بوتي، ٢٠٢٠، ص ٢٢). وأشارت بعض الدراسات إلى أن العودة التدريجية للعمل بعد فترة العلاج تُسهم في استعادة الثقة بالنفس والإحساس بالإنجاز، مما يدعم التوازن النفسي والاجتماعي معًا (خالد، ٢٠٢٥، ص ٨٥).

ثانيًا: العوامل المؤثرة في التكيف الاجتماعي.

يُعدّ التكيف الاجتماعي عملية معقّدة لا تتحقق بمعزل عن مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية والثقافية التي تتفاعل فيما بينها لتُشكّل خبرة الفرد في مواجهة المواقف الضاغطة. فالفرد لا يعيش في فراغ، بل يتأثر بنظام من العلاقات والدعم والقيم، كما تؤثر طبيعته الشخصية وخلفيته الثقافية في قدرته على المواءمة مع التغيرات المفاجئة في حياته (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٥٣).

وفي حالة النساء المصابات بسرطان الثدي، يصبح التكيف الاجتماعي أكثر حساسية، لأن المرض لا يمسّ الجسد فقط، بل يمتد ليهدد أدوارًا اجتماعية أساسية كالأمومة والأنوثة والعلاقة الزوجية.

من هنا، تتعدد العوامل التي تُحدد مدى قدرة المريضة على التكيف مع وضعها الجديد، ويمكن تناول أبرزها فيما يلي:-

١. العوامل النفسية والشخصية.

من أبرز المحددات التي تؤثر في التكيف الاجتماعي ما يتعلق بالاستعدادات النفسية للفرد وطبيعة شخصيته. فالشخص الذي يتمتع بدرجة عالية من الصلابة النفسية والمرونة الانفعالية يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، بينما قد تنهار مناعته النفسية إذا غاب عنه الإحساس بالدعم أو فقد السيطرة على الموقف.

وقد بينت دراسة أشتية (٢٠١٨، ص ٧١) أن: المساندة الاجتماعية ترتبط إيجابيًا بارتفاع الصلابة النفسية لدى مرضى السرطان، مما يعزز قدرتهم على مقاومة الانهيار النفسي والاستمرار في التفاعل الاجتماعي.

كما أشار Folkman و Lazarus (١٩٨٤، ص ٨٠) إلى أن: التكيف يعتمد بدرجة كبيرة على التقييم المعرفي للفرد للموقف الضاغط؛ فكلما فسّر الفرد الموقف بوصفه تحديًا يمكن التعامل معه، زادت احتمالات تبنيه استراتيجيات مواجهة إيجابية.

وفي حالة مريضات سرطان الثدي، تلعب الصورة الذاتية دورًا محوريًا، إذ إن التغيرات الجسدية (كالاستئصال، أو فقدان الشعر أثناء العلاج الكيميائي) قد تهزّ ثقة المرأة بنفسها، مما ينعكس سلبيًا على تواصلها الاجتماعي. لكن عندما تتمتع المرأة بإحساس إيجابي بذاتها وبإيمان قوي بقدرتها على الصمود، تصبح أكثر تقبلاً للتغيرات وأكثر اندماجًا في محيطها الاجتماعي (تومي، ٢٠١٧، ص ١٢٨).

كذلك، تُعد المرونة الانفعالية من الصفات التي تميّز الأفراد القادرين على التكيف؛ فهي تمكّن المريضة من إعادة صياغة أفكارها عن المرض وتقبّل المساعدة دون خجل. أما غياب هذه المرونة، فيؤدي إلى الانسحاب والعزلة والانغلاق على الذات، وهي أنماط شائعة لدى المريضات اللاتي يشعرن بأن مرضهن ينتقص من قيمتهن الاجتماعية (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩٦).

٢. العوامل الأسرية والزوجية.

لا يمكن الحديث عن التكيف الاجتماعي دون التوقف عند دور الأسرة والزوج تحديدًا. فالأسرة هي الإطار الأول الذي يمنح المريضة الإحساس بالأمان والاستقرار، وهي المصدر الأقرب للدعم العاطفي والمعنوي (خالد، ٢٠٢٥، ص ٨٠). وقد أظهرت الدراسات أن الدعم الزوجي هو المتغير الأكثر تأثيرًا في تحقيق التكيف الاجتماعي لدى المريضات المتزوجات، لأنه يُسهم في تخفيف القلق من فقدان الجاذبية الأنثوية أو الخوف من الرفض.

وتؤكد دراسة الحبيشي (٢٠٢٠، ص ٩٨) أن: الزوج الذي يُظهر تعاطفًا وتفهمًا تجاه مرض زوجته يُسهم في رفع معنوياتها بدرجة كبيرة، ويُعيد إليها الشعور بالقبول والانتماء، مما يُعزّز اندماجها الاجتماعي ويقلل من حدة الاكتئاب. أما غياب الدعم الأسري، فيُعدّ من أكثر العوامل خطورة على الصحة النفسية للمريضة، إذ يزيد من شعورها بالوحدة ويؤدي أحيانًا إلى تفكك العلاقات الزوجية أو فتورها العاطفي.

وفي المقابل، فإن وجود أبناء متعاونين وأسرّة متماسكة يُعيد للمريضة الإحساس بدورها الاجتماعي ويمنحها الدافع للاستمرار في العلاج بثقة (الزهراني، ٢٠٢٣، ص ٣٤٠).

٣. العوامل الاجتماعية والثقافية.

يُعتبر المجتمع الإطار الأوسع الذي يُمارس فيه الفرد تفاعلاته، ومن ثم فإن طبيعة المواقف الاجتماعية تجاه المرض لها أثر بالغ في تسهيل أو عرقلة التكيف. ففي المجتمعات التي تتبنى ثقافة الوصمة تجاه مرض السرطان، تشعر المريضة بالخجل وتميل إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، خوفًا من نظرة الشفقة أو الرفض (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٤٠). بينما في البيئات التي تتسم بالتقبل والوعي، يصبح التكيف أسهل لأن المجتمع يُقدّم للمريضة شعورًا بالتضامن والدعم بدلًا من العزلة.

وقد لاحظت دراسة تومي (٢٠١٧، ص ١٣١) أن المرضى الذين يعيشون في بيئات يسودها التعاطف المجتمعي يتمتعون بمستوى أعلى من التوازن النفسي، وأن الوعي المجتمعي حول السرطان يساهم في إزالة الحواجز النفسية أمام المريضات. وتؤكد هذه النتائج أهمية دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في نشر ثقافة الدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز النظرة الإنسانية للمرضى بعيدًا عن الخوف أو الشفقة.

أما من الناحية الثقافية، فإن منظومة القيم السائدة - مثل الإيمان بالقضاء والقدر أو التوكل على الله - قد تعمل كآلية داخلية للتكيف. فالكثير من المريضات في العالم العربي يواجهن

مرضهن بالإيمان والصبر، وهو ما يُكسبهن طمأنينة داخلية تُساعد على الاستقرار النفسي والاجتماعي (بوتي، ٢٠٢٠، ص ٢٨).

لكن الإفراط في التفسير القدرى السلبي (هذا ابتلاء لا علاج له) قد يُضعف من فاعلية المواجهة النشطة ويزيد الشعور بالعجز، لذا تظلّ التوعية النفسية ضرورية لتصحيح المفاهيم الدينية بطريقة إيجابية متوازنة.

٤. العوامل الاقتصادية والمهنية.

من العوامل التي لا تقلّ أهمية الوضع الاقتصادي والمهني للمريضة، فالعجز عن تغطية تكاليف العلاج أو فقدان العمل يُشكّلان ضغوطاً مضاعفة تقلل من فرص التكيف.

تشير دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٩٠) إلى أن: المريضات ذوات الدخل المحدود يعانين مستويات أعلى من القلق، مقارنة بالمريضات اللاتي يحصلن على دعم مالي من الأسرة أو المؤسسات الخيرية. كما أن فقدان الوظيفة أو التقاعد المبكر بسبب المرض يُضعف من الشعور بالإنجاز والهوية المهنية، مما يُفضي إلى عزلة اجتماعية وفقدان الثقة في الذات.

ومن هنا، تلعب المؤسسات الخيرية مثل مستشفى بهية دورًا جوهريًا في تعويض النقص المالي والمعنوي، إذ تقدم العلاج والدعم النفسي بالمجان، وهو ما يخفف العبء الاقتصادي ويساعد المريضة على التركيز في رحلة التعافي. هذا الدعم المادي والمعنوي يخلق بيئة علاجية آمنة تُسهم مباشرة في رفع مؤشرات التكيف الاجتماعي والالتزام بالعلاج.

٥. العوامل الصحية والطبية.

يرتبط التكيف الاجتماعي أيضًا بالحالة الصحية العامة للمريضة ومرحلة المرض ونوع العلاج المستخدم. فالمريضة في المراحل الأولى عادةً ما تكون أكثر تفاؤلاً وقدرة على التواصل، بينما المريضات في المراحل المتقدمة قد يحتجن دعمًا نفسيًا مكثفًا لمواجهة الألم والخوف من الانتكاس (الزهراني، ٢٠٢٣، ص ٣٤٨).

كما أن الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي - مثل تساقط الشعر والإرهاق المستمر - تُضعف من القدرة على المشاركة الاجتماعية. لكن الرعاية المتكاملة التي تشمل الدعم النفسي أثناء العلاج تساهم في تقليل هذه الآثار، وتُعيد للمريضة الإحساس بالسيطرة على حياتها (خالد، ٢٠٢٥، ص ٨٧).

ثالثًا: مظاهر ضعف التكيف في حالات الإصابة بالسرطان.

يُعدّ التكيف الاجتماعي من أهم مؤشرات الصحة النفسية والقدرة على التوافق مع ضغوط الحياة، غير أن الإصابة بمرض السرطان - ولا سيّما سرطان الثدي لدى النساء - تمثل تحديًا عميقًا يختبر هذا التكيف على مستويات متعددة. فحين تتلقّى المرأة خبر إصابتها، تمرّ غالبًا بمراحل متعاقبة من الصدمة، والإنكار، والخوف، والقلق، ثم تبدأ مرحلة إعادة التوازن أو الفشل في تحقيقه (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٦١).

وعندما تعجز المريضة عن الوصول إلى مستوى مقبول من التوافق النفسي والاجتماعي، تظهر مجموعة من المظاهر الدالة على ضعف التكيف، تختلف في شدتها وامتدادها تبعًا للعوامل النفسية والاجتماعية المحيطة بها.

١. الانسحاب الاجتماعي والعزلة.

تُعَدُّ العزلة الاجتماعية من أبرز مظاهر ضعف التكيف لدى مريضات السرطان. إذ تميل كثير من المريضات إلى تجنب الاختلاط بالآخرين خوفًا من الشفقة أو نظرات الفضول، أو بسبب الإرهاق الجسدي والعاطفي الناتج عن العلاج. وقد أوضحت دراسة الزهراني (٢٠٢٣، ص ٣٤٤) أن: نسبة كبيرة من المريضات المصابات بسرطان الثدي أبلغن عن انخفاض في عدد اللقاءات الاجتماعية بعد التشخيص، وأن هذا الانسحاب يتزايد مع تقدم مراحل المرض أو فقدان الشعر أو الوزن.

وفي دراسة تومي (٢٠١٧، ص ١٣٢) تبيّن أن: الشعور بالوصمة الاجتماعية يشكل عاملاً نفسيًا قويًا يؤدي إلى العزلة والانطواء، خصوصًا لدى المريضات اللاتي يشعرن بأن أنوثتهن قد انتقصت بعد الجراحة. فالمرأة التي كانت ترى نفسها محورًا للحياة الأسرية والاجتماعية قد تجد فجأة صعوبة في تقبل ذاتها.

مما يدفعها إلى تجنب الأنشطة الاجتماعية والابتعاد عن الأقارب والأصدقاء. إلا أن هذه العزلة ليست دائمًا اختيارًا واعيًا، بل قد تكون آلية دفاع نفسية تلجأ إليها المريضة لتجنب المواجهة

أو لحماية ذاتها من الألم النفسي الناتج عن نظرات الآخرين (Lazarus & Folkman، ١٩٨٤، ص ٩٠).

ومع مرور الوقت، تتحول هذه الآلية من حماية مؤقتة إلى سلوك انعزالي مزمن يفاقم الاضطراب النفسي ويضعف فرص التكيف.

٢. اضطراب العلاقات الأسرية والزوجية.

من المظاهر البارزة لضعف التكيف في حالات سرطان الثدي تدهور العلاقات الأسرية أو الزوجية. فالمرض يفرض على المرأة تحديات جديدة تتعلق بدورها كزوجة وأم، وقد يؤدي إلى تغيير ديناميكية الأسرة بأكملها (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩٨).

فالمريضة قد تشعر بالذنب تجاه زوجها أو أطفالها، أو تخشى من أن تكون عبئاً عليهم، بينما قد يجد بعض الأزواج صعوبة في التعامل مع المريضة بسبب ضعف الوعي النفسي أو الخوف من المستقبل. وقد كشفت دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٨٨) أن المريضات اللواتي يفقدن الدعم الأسري والزوجي يعانين مستويات أعلى من الاكتئاب، وتقل لديهن الرغبة في المشاركة الاجتماعية.

كما بينت أن الدعم العاطفي من الزوج يُعتبر العامل الأكثر تأثيراً في تحقيق التكيف الاجتماعي الإيجابي. وفي المقابل، أظهرت دراسة أشتية (٢٠١٨، ص ٧٢) أن غياب التواصل الأسري أو زيادة التوترات داخل البيت يؤدي إلى ضعف القدرة على التكيف، ويزيد من شعور

المريضة بالوحدة والعجز.

من جهة أخرى، تشير دراسات علم النفس الإكلينيكي إلى أن بعض المريضات يعانين من تراجع الثقة بالنفس والقدرة على التواصل الحميم بعد العمليات الجراحية، مما يحدث فجوة عاطفية بين الزوجين إذا لم يتعامل معها الطرف الآخر بحساسية ووعي كافٍ (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٤١). وتؤدي هذه الفجوة إلى فقدان الشعور بالأمان والانتماء، وهما ركيزتان أساسيتان للتكيف الاجتماعي السليم.

٣. القلق والاكتئاب واضطرابات المزاج.

يُعدّ القلق والاكتئاب من أكثر المؤشرات النفسية لضعف التكيف شيوعاً بين مريضات السرطان. فقد أوضحت دراسة العنزي (٢٠٢٣، ص ٣٧) أن الدعم الاجتماعي المنخفض يرتبط بارتفاع ملحوظ في معدلات القلق والاكتئاب، وأن المريضات اللواتي لا يتلقين دعماً نفسياً منتظماً أكثر عرضة لفقدان الحافز للعلاج.

كما أظهرت دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٨٢) أن مستويات القلق النفسي ترتفع بصورة أكبر لدى المريضات المتزوجات اللاتي يشعرن بعدم تفهم أزواجهن لطبيعة المرض. ويصف عبد الغفار (٢٠٢٠، ص ٦٦) هذه الحالة بأنها: "تآكل تدريجي في الطاقة النفسية والاجتماعية للمريض، يبدأ بالقلق ويتطور إلى اكتئاب مزمن ينعكس على العلاقات الأسرية والمهنية".

وفي هذا السياق، تلعب المرونة النفسية دورًا محوريًا في كسر هذه الحلقة السلبية، إذ تساعد المريضة على تحويل الأفكار السلبية إلى تحديات قابلة للتغلب، لا إلى أحكام قدرية تثبّت العزيمة. لكن غياب الإرشاد النفسي في بعض البيئات العلاجية يجعل الكثير من المريضات حبيسات لهذه المشاعر السلبية لفترات طويلة.

٤. ضعف الهوية الاجتماعية والشعور بفقدان الدور.

من مظاهر ضعف التكيف أيضًا تراجع الإحساس بالهوية الاجتماعية، خاصة لدى النساء اللواتي فقدن القدرة على ممارسة أدوارهن اليومية. فقد أشار بوتّي (٢٠٢٠، ص ٢٥) إلى أن الإحساس بالجدوى الاجتماعية والقدرة على الإنتاج من أهم مكونات جودة الحياة، وأن فقدان هذه العناصر يؤدي إلى فراغ نفسي حاد. فالمريضة التي كانت موظفة أو قائدة في مجالها قد تجد نفسها فجأة محصورة في دور "المريضة"، وهو ما يولّد شعورًا بالإقصاء من المجتمع. 1441

وإذا لم تُوفّر لها بيئة داعمة تسمح بالمشاركة الرمزية أو التطوعية، فقد تتطور هذه الحالة إلى عجز اجتماعي مكتسب، أي أن المريضة تقتنع بأنها غير قادرة على الاندماج أو الإنجاز مهما حاولت (تومي، ٢٠١٧، ص ١٣٤). وفي المجتمعات العربية تحديدًا، حيث ترتبط قيمة المرأة غالبًا بدورها الأسري، يزداد الضغط النفسي على المريضة التي لا تستطيع القيام بواجباتها تجاه الأسرة والأبناء، مما يزيد من إحساسها بالعجز.

٥. فقدان المعنى والأمل.

يرتبط ضعف التكيف أحيانًا بفقدان الإحساس بالمعنى والأمل في المستقبل، وهو ما عبّر عنه Lazarus و Folkman (١٩٨٤، ص ٩٣) بمفهوم: «الاحتراق النفسي الناتج عن استنفاد الموارد الإدراكية والانفعالية»، فالمرأة التي تستسلم لفكرة أن المرض نهاية الطريق تُصاب تدريجيًا باللامبالاة، ويتراجع التزامها بالعلاج أو المشاركة الاجتماعية.

وقد لاحظت دراسة أشتية (٢٠١٨، ص ٧٤) أن المرضى الذين يتمتعون بإيمان قوي بمعنى الحياة وأمل في الشفاء يُظهرون مستويات أعلى من التكيف، بينما ترتفع معدلات الاكتئاب لدى أولئك الذين يفتقدون هذا المعنى. وتوصي دراسات عدة - منها دراسة الحبشي (٢٠٢٠، ص ٩٩) - بضرورة إدماج البرامج الدينية والروحية ضمن منظومة الدعم النفسي للمريضات، لما لها من أثر بالغ في إعادة بناء المعنى والرجاء في الحياة.

٦. انخفاض جودة الحياة.

أحد أهم مظاهر ضعف التكيف يتمثل في انخفاض جودة الحياة، وهو مؤشر شامل يجمع بين الأبعاد النفسية والجسدية والاجتماعية. وتوضح دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٩١) أن ضعف جودة الحياة يرتبط سلبيًا بمستوى الدعم الاجتماعي المُدرَك، وأن المريضات اللاتي يشعرن بالعزلة أو الإهمال من الأسرة والمجتمع يعانين من إجهاد مزمن واضطرابات في النوم والشهية والمزاج.

كما تبين في دراسة العنزي (٢٠٢٣، ص ٤٢) أن تراجع جودة الحياة ينعكس على صورة

الذات وعلى العلاقات الاجتماعية، ما يؤدي إلى حلقة مفرغة من التدهور النفسي والاجتماعي.

المبحث الثالث: العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي.

أولاً: الأسس النظرية للعلاقة بين المتغيرين.

تُعَدّ العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي من العلاقات الجوهرية في ميدان علم النفس الإكلينيكي والاجتماعي، إذ تعكس قدرة الفرد على الاستفادة من المساندة النفسية والاجتماعية التي يتلقاها لمواجهة الأزمات، وتحقيق التوازن بين ذاته ومجتمعه.

وقد تناولت العديد من النظريات النفسية هذا الترابط، سواء من منظور المرونة والصمود

أو من منظور الدعم الاجتماعي والمواجهة المعرفية. ويستعرض هذا القسم أبرز الأطر النظرية التي يمكن الاستناد إليها في تفسير العلاقة بين المتغيرين في الدراسة الحالية.

١. نظرية الصمود النفسي (Resilience Theory).

تقوم نظرية الصمود النفسي على افتراض أساسي مفاده أن الأفراد قادرون على التكيف

الإيجابي في مواجهة الصعوبات والمحن، من خلال تفعيل الموارد النفسية والاجتماعية التي

يتملكونها (Masten, 2014، ص ٧). وتُعرّف المرونة أو الصمود النفسي بأنها «قدرة الفرد على

العودة إلى حالة التوازن بعد المرور بموقف ضاغط أو أزمة تهدد استقراره النفسي والاجتماعي»

(Connor & Davidson, 2003، ص ٧٨).

في ضوء هذه النظرية، يُعد الدعم النفسي أحد أهم العوامل المحفزة للصمود، إذ يُسهم في تمكين المريضة من إعادة بناء ثقتها بنفسها بعد الإصابة، ويُزوّدها باستراتيجيات معرفية وسلوكية تُعينها على التعامل مع الموقف المرضي دون انهيار أو انسحاب.

وقد أكدت دراسة مجلة كلية التربية - جامعة الأزهر (٢٠٢٣، ص ٣٤٢) أن المريضات اللاتي يتمتعن بدعم نفسي مستمر يظهرن مستويات أعلى من الصمود والمرونة الانفعالية، مما ينعكس إيجابًا على قدرتهن في استعادة التوازن والتكيف الاجتماعي بعد العلاج.

وتتضح تطبيقات هذه النظرية في ممارسات مستشفى بهية، التي تُركز في برامجها العلاجية على بناء الصمود النفسي من خلال جلسات الدعم الجماعي ومجموعات المشاركة المفتوحة. إذ توفر بيئة تشجع المريضة على التعبير عن مشاعرها، والتعرف إلى قصص نجاح مريضات أخريات، فيتحول الألم إلى دافع للتحدي، والضعف إلى وسيلة للنمو النفسي والاجتماعي (خالد، ٢٠٢٥، ص ٨٤).

٢. نظرية الدعم الاجتماعي (Social Support Theory).

تُعَدُّ نظرية الدعم الاجتماعي من أكثر النظريات ارتباطًا بموضوع الدراسة، إذ تفسر كيف تؤدي المساندة الاجتماعية والنفسية إلى تحسين قدرة الفرد على التعامل مع الضغوط. وتقرض هذه النظرية أن الدعم الاجتماعي - سواء كان عاطفيًا أو معرفيًا أو سلوكيًا - يعمل كحاجز وقائي ضد التأثيرات السلبية للضغوط الحياتية (Cohen & Wills, 1985، ص ٣١٠).

كما تشير النظرية إلى أن الدعم لا يغيّر الموقف الضاغط ذاته، لكنّه يُعدّل من طريقة استجابة الفرد له عن طريق تعزيز الشعور بالانتماء والأمان وتقوية الثقة بالنفس (Lakey & Cohen, 2000، ص ٣٠).

ومن هذا المنطلق، يصبح الدعم النفسي أداةً فاعلة في تحسين التكيف الاجتماعي، إذ يساعد المريضة على إعادة تفسير تجربتها المرضية بصورة أكثر إيجابية، ويجعلها أكثر قدرة على التواصل مع الأسرة والمجتمع دون شعور بالخجل أو النقص. وتتفق هذه النظرية مع نتائج دراسة جامعة دميّاط (خالد، ٢٠٢٥، ص ٧٥)، التي أوضحت أن ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي المُدرّك يرتبط بزيادة جودة الحياة والرضا الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي.

كما بيّنت الدراسة أن أكثر أشكال الدعم تأثيرًا هو الدعم العاطفي من الأسرة والفريق الطبي، وهو ما يعكس الدور الحيوي للمساندة الإنسانية في تعزيز التكيف الاجتماعي حتى في ظل المعاناة الجسدية. وفي السياق العربي، أوضحت دراسة أشّتية (٢٠١٨، ص ٧٢) أن المساندة الاجتماعية تمثل مصدرًا مباشرًا للصّابة النفسية والقدرة على مواجهة الألم والضغط. حيث يساعد الإحساس بالتقدير والاهتمام على خفض مستويات القلق والاكتئاب، وتحسين القدرة على أداء الأدوار الاجتماعية. وهذا التفاعل بين الدعم النفسي والصّابة الاجتماعية هو ما يفسّر نجاح بعض المريضات في الاندماج الإيجابي بعد العلاج.

٣. نظرية المواجهة والتكيف (Lazarus & Folkman, 1984).

تُعَدّ هذه النظرية من أكثر النماذج تفسيرًا للعلاقة بين الضغوط النفسية واستجابات الفرد

للتكيف معها. وقد قدم Lazarus و Folkman (١٩٨٤، ص ٩٠) تصورًا متكاملًا للمواجهة

النفسية يقوم على مرحلتين أساسيتين:-

(1) التقييم المعرفي للموقف: حيث يُقيّم الفرد الموقف الضاغط من حيث خطورته وقدرته

على التعامل معه.

(2) المواجهة الفعلية: وهي الاستراتيجيات التي يعتمد عليها الفرد للتقليل من أثر الموقف

النفسي أو الاجتماعي السلبي. وتقتضى النظرية أن الدعم النفسي والاجتماعي يسهم

في تعديل عملية التقييم المعرفي، بحيث يُعيد تشكيل نظرة الفرد إلى الموقف المهدّد،

من كونه أزمة لا يمكن السيطرة عليها إلى تجربة يمكن التعامل معها بمرونة وثقة. 1441

وبالتالي، فإن الدعم النفسي يعمل كوسيط معرفي يُسهم في تحويل الضغوط إلى تحديات

قابلة للإدارة بدلًا من كونها تهديدًا وجوديًا. في هذا الإطار، أشارت دراسة مجلة كلية التربية-

جامعة الأزهر (٢٠٢٣، ص ٣٤٧) إلى أن المريضات اللاتي تلقين إرشادًا نفسيًا مبنيا على إعادة

التقييم المعرفي أظهرن تراجعًا واضحًا في مؤشرات الكرب النفسي، وارتفاعًا في مؤشرات التكيف

الاجتماعي والانفتاح الأسري.

كما تدعم نتائج دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٩٠) هذا التصور، حيث أثبتت أن: برامج الدعم النفسي القائمة على الحوار والإرشاد المعرفي ساعدت المريضات على الالتزام بالعلاج واستعادة توازنهن الانفعالي والاجتماعي. ويمكن القول إن هذه النظرية تفسر بعمق الآلية التي يتحول بها الدعم النفسي من مجرد تعاطف أو نصيحة إلى قوة معرفية وسلوكية تُعيد بناء الذات وتمنحها القدرة على التكيف.

تتكامل النظريات الثلاث السابقة لتُقدّم رؤية شاملة لطبيعة العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي. فنظرية الصمود النفسي تبرز البعد الداخلي للمرونة والقدرة على النهوض بعد الأزمات، بينما توضح نظرية الدعم الاجتماعي أهمية الشبكات الإنسانية والعلاقات في تخفيف الضغوط وتحقيق الانسجام الاجتماعي، أما نظرية المواجهة والتكيف فتفسر العمليات العقلية والانفعالية التي من خلالها يُحوّل الفرد الدعم إلى سلوك تكيفي فعال.

ومن خلال دمج هذه الأطر النظرية يمكن فهم كيف يصبح الدعم النفسي في المؤسسات العلاجية- مثل مستشفى بهية- عاملاً حاسماً في تمكين المريضات المتزوجات من تجاوز الأزمة الصحية، وتحقيق توازن نفسي واجتماعي يسمح لهن بالعودة إلى أدوارهن الأسرية والمجتمعية بثقة وإيجابية.

ثانيًا: تحليل دور الدعم النفسي كعامل وسيط في تحسين التكيف الاجتماعي.

يُعدّ الدعم النفسي أحد أهم المتغيرات الوسيطة التي تفسّر قدرة الفرد على تحقيق التكيف الاجتماعي في المواقف الضاغطة، ولا سيّما في حالة مريضات سرطان الثدي اللواتي يواجهن تجربة مركبة تمسّ الجسد والوجدان والعلاقات الإنسانية في آنٍ واحد.

فالدعم النفسي لا يعمل في فراغ، بل يتفاعل مع مجموعة من العوامل النفسية والاجتماعية التي تُسهم مجتمعةً في بناء منظومة التكيف الشامل. وتبرز أهمية هذا الدور الوسيط في أنه يُحوّل المسار الانفعالي للمريضة من الانهيار والعزلة إلى الاستبصار والتقبل والاندماج.

١. الدعم النفسي كجسر بين الضغوط النفسية والاستجابة الاجتماعية.

عندما تواجه المرأة خبر إصابتها بسرطان الثدي، تمرّ بعدة مراحل انفعالية متشابكة تبدأ بالصدمة وتنتهي بالتقبل. وفي أثناء هذه المراحل، يلعب الدعم النفسي دورًا حاسمًا في تخفيف التفاعل الانفعالي السلبي وتحويله إلى دافعية إيجابية نحو المواجهة.

تُظهر دراسة الزهراني (٢٠٢٣، ص ٣٣٨) أن: ارتفاع مستوى الدعم الاجتماعي يرتبط بانخفاض معدلات الكرب النفسي والقلق، وهو ما يؤكد أن الدعم لا يقتصر على التخفيف الانفعالي، بل يعمل كجسر يربط بين الحالة النفسية للفرد واستجاباته الاجتماعية.

فمن خلال جلسات الإرشاد النفسي التي تعتمد على إعادة التقييم المعرفي - كما في نموذج Lazarus & Folkman (١٩٨٤) - تتعلم المريضة كيف تعيد تفسير تجربتها مع المرض بطريقة جديدة، فتتحول من كونها ضحية لحدث مأساوي إلى فاعل يمتلك القدرة على السيطرة والتأثير. هذه العملية الإدراكية هي جوهر الدور الوسيط للدعم النفسي؛ فهي تربط بين الإدراك الداخلي والتمثل الاجتماعي الخارجي.

٢. أثر الدعم النفسي في إعادة بناء الصورة الذاتية.

تؤثر الإصابة بسرطان الثدي في بنية الهوية الذاتية للمرأة، خصوصًا إذا تطلب العلاج استئصالًا جزئيًا أو كليًا للثدي. ويؤدي ذلك في كثير من الحالات إلى فقدان الشعور بالجاذبية أو النقص الأنثوي، وهو ما يحدث اضطرابًا في تقدير الذات، ومن ثم في علاقاتها الاجتماعية والزوجية (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩٨).

لكن الدعم النفسي - سواء قُدّم من متخصصين أو من الأسرة والمجتمع - يعمل كآلية ترميم للذات، فهو يساعد المريضة على إعادة بناء هويتها النفسية وتقبل جسدها الجديد ضمن واقع اجتماعي آمن.

وتؤكد دراسة خالد (٢٠٢٥، ص ٨٣) أن برامج الدعم النفسي التي تُنظّم داخل المستشفيات المصرية - وعلى رأسها مستشفى بهية - تُسهم في تحسين الصورة الذاتية للمريضة بدرجة كبيرة، وتُعيد إليها الشعور بالثقة والرضا، مما يُحفّزها على العودة للاندماج الاجتماعي بعد العلاج.

ويرتبط ذلك مباشرةً بمفهوم الصمود النفسي (Resilience) كما صاغته Masten (٢٠١٤)، الذي يرى أن الأزمات الكبرى يمكن أن تكون نقطة انطلاق لإعادة التوازن وإنتاج معنى جديد للحياة. فالدعم النفسي هنا لا يغيّر الماضي، بل يُعيد تأويله بطريقة تسمح للمريضة باستعادة هويتها الاجتماعية والمضي قدمًا.

٣. المساندة العاطفية كوسيط بين الألم النفسي والقدرة على التواصل.

تبين من الدراسات السابقة أن المساندة العاطفية تمثل أقوى أشكال الدعم النفسي تأثيرًا في مسار التكيف الاجتماعي. فهي تُخفف من الإحساس بالوحدة والرفض، وتُعيد للمريضة القدرة على التواصل الإنساني دون خوف من نظرة الآخرين (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٣٩).

وقد أكدت دراسة جامعة دمياط (خالد، ٢٠٢٥، ص ٧٩) أن المريضات اللاتي حظين بمساندة عاطفية مستمرة من الأسرة والأصدقاء أظهرن مؤشرات مرتفعة في التكيف الأسري والاجتماعي.

ويُفسّر ذلك وفقًا لنظرية الدعم الاجتماعي (Cohen & Wills, 1985) التي تذهب إلى أن الدعم العاطفي يُقلّل من تأثير الضغوط على الصحة النفسية من خلال تفعيل آليات "التوازن الانفعالي" التي تسمح للفرد بالتعبير عن مشاعره بحرية وتلقّي القبول دون خوف من الحكم الاجتماعي.

هذه المساندة تمثل بذلك وسيطاً نفسياً واجتماعياً يربط بين الألم الشخصي والمشاركة المجتمعية. كما تشير نتائج دراسة أشتية (٢٠١٨، ص ٧٣) إلى أن العلاقات الاجتماعية الإيجابية تُحفز الصلابة النفسية، وتجعل المريض أكثر استعداداً للتفاعل مع الآخرين والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، حتى وإن كان ما يزال في مراحل العلاج الأولى.

٤. الدور الوسيط للدعم النفسي في الالتزام العلاجي.

يُعتبر الالتزام بالعلاج أحد المؤشرات الجوهرية على مستوى التكيف الاجتماعي والنفسي للمريض. وقد بينت دراسة الزهراني (٢٠٢٣، ص ٣٤٧) أن المريضات اللواتي تلقين دعماً نفسياً مستمراً أظهرن التزاماً أعلى بالمواعيد العلاجية، وتعاوناً أفضل مع الفريق الطبي مقارنة بغيرهن.

ويرى Folkman و Lazarus (١٩٨٤، ص ٩٥) أن هذا الارتباط ناتج عن تعديل الدعم

النفسي لطريقة تقييم الموقف المرضي، بحيث تتحوّل النظرة إلى العلاج من «عبء مؤلم» إلى «وسيلة فعالة للشفاء والتحكم بالحياة».

كما أظهرت دراسة الحبشي (٢٠٢٠، ص ٩٧) أن الدعم الأسري، خصوصاً من الزوج، يُعدّ محفزاً قوياً للالتزام بالعلاج والاستمرار فيه، لأنه يمنح المريضة الإحساس بالأمان والانتماء، ويُخفف من الضغوط التي قد تدفعها إلى الانسحاب أو الاكتئاب، وبالتالي، يعمل الدعم النفسي هنا كحلقة وصل بين العلاج الطبي والنتائج الاجتماعية، فهو لا يُحسن الحالة المزاجية فحسب، بل يرفع أيضاً فاعلية العلاج الجسدي بفضل تزايد الدافعية والالتزام.

٥. الدعم النفسي كمحرك لإعادة الاندماج الاجتماعي.

من أبرز الأدوار التي يلعبها الدعم النفسي أنه يُعيد للمريضة القدرة على الانخراط في الحياة الاجتماعية بعد انتهاء العلاج. فالمريضة التي تتلقى دعمًا نفسيًا منتظمًا تجد في نفسها الشجاعة للعودة إلى بيئة العمل أو الأنشطة الاجتماعية.

ويُشير موقع مستشفى بهية (٢٠٢٥، ص ٣) إلى أن ٧٠٪ من المريضات اللاتي شاركن في جلسات الدعم الجماعي أبدن رغبة في العمل التطوعي أو التوعية بمرض السرطان بعد التعافي، وهو ما يُعدّ مؤشرًا مباشرًا على النجاح في تحقيق التكيف الاجتماعي الكامل. كما أوضحت دراسة تومي (٢٠١٧، ص ١٣٣) أن: الدعم الاجتماعي والنفسي يسهم في إعادة بناء العلاقات الإنسانية، ويُعزز من الإحساس بالانتماء، وهو ما يرفع جودة الحياة ويقلل الشعور بالعزلة.

وهكذا يصبح الدعم النفسي ليس مجرد وسيلة لمواجهة الألم، بل أداة لإعادة دمج المريضة في دورة الحياة الاجتماعية وإعادة تعريف ذاتها ضمن سياقها الأسري والمجتمعي. من خلال التحليل السابق، يتبين أن الدعم النفسي يشكّل العامل الوسيط الرئيس بين الضغوط الناتجة عن المرض وبين قدرة المريضة على التكيف الاجتماعي.

فهو لا يعمل كعنصر خارجي فقط، بل كمنظومة داخلية تُعيد تنظيم الاستجابات الانفعالية والمعرفية والاجتماعية للمريضة. وكلما كان الدعم النفسي أكثر تكاملاً - عاطفياً وأسريراً ومؤسسياً - ارتفعت فرص تحقيق التوازن الاجتماعي، والالتزام العلاجي، واستعادة الهوية الاجتماعية. ولذلك فإن تصميم برامج الدعم النفسي في المستشفيات - كما في مستشفى بهية - يجب أن ينطلق من فهم هذا الدور الوسيط بوصفه المحرك الأساس للتكيف الشامل وليس مجرد خدمة مساندة.

الإطار المفاهيمي للدراسة الحالية.

يُعَدُّ الإطار المفاهيمي للدراسة بمثابة البناء الذهني الذي يجمع بين الأسس النظرية والنتائج التطبيقية لتوضيح العلاقة بين متغيري الدراسة: الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات المصابات بسرطان الثدي.

ويهدف هذا الإطار إلى تقديم تصور متكامل يربط بين المفاهيم المجردة والنماذج العملية التي تفسر كيف يُسهم الدعم النفسي في تحسين قدرة المريضة على التكيف الاجتماعي في ضوء مجموعة من المتغيرات الوسيطة.

المتغير المستقل - الدعم النفسي.

يُشير الدعم النفسي في هذا الإطار إلى مجموع العمليات والأنشطة التي تهدف إلى التخفيف من الضغوط النفسية والانفعالية الناجمة عن المرض، من خلال تقديم المساندة العاطفية والمعرفية والسلوكية والاجتماعية للمريضة (خالد، ٢٠٢٥، ص ٧٠).

ويشمل هذا المتغير ثلاثة أبعاد رئيسية:

1. **الدعم العاطفي:** ويتمثل في إظهار التعاطف والاهتمام والقبول غير المشروط من قبل الأسرة أو الفريق الطبي، مما يُعزّز الشعور بالأمان والطمأنينة (الحبيشي، ٢٠٢٠، ص ٩٥).

2. **الدعم المعرفي:** ويُعبّر عن تزويد المريضة بالمعلومات والإرشادات النفسية حول طبيعة المرض والعلاج، مما يساعدها على إعادة تفسير الموقف المرضي بطريقة إيجابية (Lazarus & Folkman, 1984، ص ٩٣).

3. **الدعم السلوكي والاجتماعي:** ويتجلى في المساعدات العملية أو المادية، وتنظيم الأنشطة العلاجية والاجتماعية التي تُعيد للمريضة دورها في المجتمع (العنزي، ٢٠٢٣، ص ٤٠). من ثمّ، يمثل الدعم النفسي في هذا الإطار المتغير المستقل الأساسي الذي يؤثر بدرجات متفاوتة في مستوى التكيف الاجتماعي للمريضة.

المتغير التابع - التكيف الاجتماعي.

يُشير التكيف الاجتماعي إلى قدرة المريضة على التفاعل الإيجابي مع بيئتها الاجتماعية واستمرار علاقاتها الأسرية والزوجية والمهنية رغم الضغوط الناتجة عن المرض. ويُقاس التكيف الاجتماعي في ضوء ثلاثة أبعاد رئيسية (عبد الغفار، ٢٠٢٠، ص ٦٦): -

1. التكيف الأسري: قدرة المريضة على الحفاظ على توازن العلاقات الأسرية والزوجية،

واستمرار الأدوار العائلية بصورة مستقرة.

2. التكيف الاجتماعي العام: اندماج المريضة في المجتمع من خلال الأنشطة الاجتماعية

والعمل التطوعي أو المهني بعد التعافي.

3. التكيف النفسي الداخلي: الشعور بالرضا عن الذات والقدرة على ضبط الانفعالات في

مواجهة التحديات. ويتحدد مستوى هذا التكيف وفقًا لطبيعة الدعم الذي تتلقاه المريضة

من أسرته ومجتمعها ومؤسساتها العلاجية.

المتغيرات الوسيطة.

تُظهر الدراسات الحديثة أن العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي ليست مباشرة

تمامًا، بل تتأثر بعدد من العوامل الوسيطة التي تُعزز أو تُضعف هذا الارتباط (الزهراني، ٢٠٢٣، ص ١٤٧،

ص ٣٤٧؛ أشتية، ٢٠١٨، ص ٧٣).

وتتمثل أهم هذه العوامل فيما يلي:-

1. الخصائص الديموغرافية: مثل العمر، ومدة الزواج، والمستوى التعليمي، والوضع

الاقتصادي، ومرحلة المرض.

2. الصلابة النفسية والمرونة الانفعالية: حيث تؤدي المساندة الاجتماعية إلى تنمية

الصمود النفسي الذي يُعدّ وسيطاً قوياً في تحقيق التكيف الإيجابي (Masten, 2014، ص ٢٢).

3. مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي: إذ تسهم الثقافة الداعمة في تخفيف الوصمة وتعزيز الاندماج الاجتماعي (تومي، ٢٠١٧، ص ١٣٠).

4. نوع الدعم المؤسسي: فالدعم الذي تقدمه المستشفيات أو الجمعيات الخيرية مثل مستشفى بهية يُعدّ وسيطاً تنظيمياً يُكَمِّل الدور الأسري والمجتمعي (موقع مستشفى بهية، ٢٠٢٥، ص ٣).

العلاقات المفترضة بين المتغيرات.

استناداً إلى ما سبق من تحليل نظري وتطبيقي، يمكن صياغة العلاقات المفترضة بين

متغيرات الدراسة على النحو الآتي:-

1. علاقة مباشرة موجبة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي؛ فكلما زاد مستوى الدعم بمختلف أنواعه، ارتفع مستوى التكيف الاجتماعي للمريضة (خالد، ٢٠٢٥؛ مجلة كلية التربية- جامعة الأزهر، ٢٠٢٣).

2. علاقة غير مباشرة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي عبر المتغيرات الوسيطة، مثل الصمود النفسي والوعي الثقافي والدعم الأسري، حيث يُسهم الدعم النفسي في تعزيز هذه العوامل، التي بدورها ترفع مستوى التكيف الاجتماعي (أشتية، ٢٠١٨؛

(Masten, 2014).

3. علاقة عكسية بين غياب الدعم النفسي ومظاهر ضعف التكيف الاجتماعي؛ إذ يؤدي

انخفاض الدعم إلى ارتفاع مستويات القلق والعزلة والاكتئاب، وبالتالي تدهور جودة

الحياة الاجتماعية (العنزي، ٢٠٢٣؛ الحبشي، ٢٠٢٠).

إجراءات الدراسة الميدانية.

تم إجراءات الدراسة الميدانية، كما يلي:-

(1) عينة الدراسة.

(أ) عينة الدراسة الاستطلاعية: وتكونت من (٣٨) من مريضات سرطان الثدي.

(ب) عينة الدراسة الأساسية: تكونت عينة الدراسة الأساسية من (٥٦) من مريضات

سرطان الثدي.

جدول (١)

توزيع العينة الأساسية من مريضات سرطان الثدي تبعاً للمتغيرات الديموجرافية.

المتغيرات			العمر		مدة الإصابة		المشاركة في جلسات الدعم		نوع العلاج	
العدد	أقل من ٣٥ سنة	من ٣٥ فأكثر	أقل من ٣ سنوات	٣ سنوات فأكثر	لا	نعم	كيميائي	إشعاعي	جراحي	
٢٤	٣٢	٢٦	٣٠	٢٩	٢٧	٢٧	٢٧	١٩	١٠	

(2) أداة الدراسة.

تم إعداد الاستبانة مكونة من (١٠) عبارات موزعة بعدد من (٥) عبارات وبعد عن التكيف الاجتماعي، ويشمل (٥) عبارات، ثم تم وضع خمسة بدائل للاستجابة على الاستبانة، وهي (دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، أبدًا) وطريقة تصحيحها (٥، ٤، ٣، ٢، ١) على الترتيب، وتم التحقق من الخصائص السيكومترية للاستبيان كما يلي:-

أولاً- صدق الاستبيان: وتم التحقق منه على النحو التالي:-

صدق الاتساق الداخلي: تم تطبيق الاستبيان على عدد (٣٨) من مريضات سرطان الثدي، وهم يمثلوا عينة الدراسة الاستطلاعية، وذلك للتحقق من صدق الاتساق الداخلي للاستبانة من خلال حساب ارتباط درجة كل عبارة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه، ويوضح ذلك جدول (٢).

جدول (٢).

معاملات ارتباط درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ن = (٣٨).

بعد (الدعم النفس).		بعد (التكيف الاجتماعي).	
العبارة	الارتباط بالبعد	العبارة	الارتباط بالبعد
١	**٠,٦٠٥	١	**٠,٧٥٤
٢	**٠,٣٩٢	٢	**٠,٦٧١
٣	**٠,٧٣١	٣	**٠,٧٣١
٤	**٠,٦٥٧	٤	**٠,٨٦١
٥	**٠,٤٨٨	٥	**٠,٥٨٨

ويتضح من جدول (٢) أن جميع معاملات الارتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عند مستوى (٠,٠١)، مما يدل على اتساق داخلي لعبارات الاستبيان.

ثانياً- ثبات الاستبانة: تم حساب ثبات استبانة دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا)، بطريقة ألفا كرونباخ Cronbach Alpha، فكانت كما هو موضح بالجدول التالي:-

جدول (٣)

معاملات الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لبعدي الاستبانة والاستبانة ككل.

محاور الاستبيان.	عدد العبارات.	معامل ثبات ألفا كرونباخ.
بعد (الدعم النفس).	٥	٠,٧٩٤
بعد (التكيف الاجتماعي).	٥	٠,٧٧٣
الاستبانة ككل.	١٠	٠,٨٢٣

يتضح من الجدول السابق أن جميع معاملات الثبات مرتفعة؛ مما يؤكد تمتع استبانة دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا) بدرجة مرتفعة من الثبات، ويدل على صلاحيتها للتطبيق.

3) الإجابة عن أسئلة الدراسة.

أولاً- الإجابة عن السؤال الأول.

«ما العلاقة الارتباطية بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي؟» للإجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson's correlation coefficient) باستخدام برنامج (SPSS V.26)، لحساب معاملات الارتباط بين درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على الدعم النفسي ودرجاتهن على التكيف الاجتماعي، ويوضح العرض التالي النتائج التي تم التوصل إليها:-

جدول (٤)

معامل الارتباط الخطي لبيرسون بين درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على الدعم النفسي ودرجاتهن على التكيف الاجتماعي.

المتغيرات	التكيف الاجتماعي	مستوى الدلالة
الدعم النفسي	٠,٦٨٦**	٠,٠٠

** دالة عند مستوى ٠,٠١.

يتضح من الجدول السابق وجود علاقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً عند مستوى

(٠,٠١) بين درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على: (الدعم النفسي) ودرجاتهن

على: (التكيف الاجتماعي).

ثانيًا - الإجابة عن السؤال الثاني.

هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا للعمر: (أقل من ٣٥ سنة - ٣٥ سنة فأكثر)؟ للإجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson's correlation coefficient) باستخدام برنامج (SPSS V.26)، لحساب دلالة الفروق الإحصائية لاستجابات أفراد عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على الاستبانة تبعًا للعمر، ويوضح جدول (٥) ذلك.

جدول (٥)

دلالة الفروق الإحصائية لاستجابات عينة الدراسة على الاستبانة تبعًا للعمر.

المتغير	العمر	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
بعد (الدعم النفس).	أقل من ٣٥	٢٤	١٩,٤١	٢,٧٤	٢,٢٦	دالة عند ٠,٠٥
	٣٥ سنة وأكثر	٣٢	١٧,٢١	٤,٠٩		
بعد (التكيف الاجتماعي).	أقل من ٣٥	٢٤	١٨,٦٦	٢,١٨	٣,٦٥	دالة عند ٠,٠١
	٣٥ سنة وأكثر	٣٢	١٥,٨٤	٣,٥٦		

من الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠٥) بين متوسطي درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) في اتجاه الأقل من ٣٥ سنة، وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي درجات عينة الدراسة

من مريضات سرطان الثدي على بعد: (التكيف الاجتماعي) في اتجاه: (الأقل من ٣٥ سنة).

ثالثًا - الإجابة عن السؤال الثالث.

هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعًا مدة الإصابة (أقل من ٣ سنوات - ٣ سنوات فأكثر)؟ للإجابة على هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون (Pearson's correlation coefficient) باستخدام برنامج (SPSS V.26)، لحساب دلالة الفروق الإحصائية لاستجابات أفراد عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على الاستبانة تبعًا لمدة الإصابة، ويوضح جدول (٦) ذلك.

جدول (٦)

دلالة الفروق الإحصائية لاستجابات عينة الدراسة على الاستبانة تبعًا لمدة الإصابة.

المتغير	مدة الإصابة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
بعد (الدعم النفس).	أقل من ٣ سنوات	٢٦	١٩,٩٢	٢,٣٦	٣,٧٨	دالة عند ٠,٠١
	٣ سنوات فأكثر	٣٠	١٦,٦٣	٤,٠٣		
بعد (التكيف الاجتماعي).	أقل من ٣ سنوات	٢٦	١٨,٧٣	٢,٣٢	٣,٩٣	دالة عند ٠,٠١
	٣ سنوات فأكثر	٣٠	١٥,٦	٣,٤		

من الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي

درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) وبعد: (التكيف

الاجتماعي) في اتجاه المريضات ذوات مدة الإصابة: (أقل من ٣ سنوات).

رابعاً - الإجابة عن السؤال الرابع.

هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي

تبعاً للمشاركة في جلسات الدعم (نعم - لا)؟

وللإجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار «ت» للمجموعات المستقلة (Indepen-

dent Samples t-test) باستخدام برنامج (SPSS V.26) لحساب دلالة الفروق الإحصائية

لاستجابات أفراد عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على الاستبانة تبعاً للمشاركة في

جلسات: (الدعم النفسي)، ويوضح جدول (٧) ذلك.

جدول (٧)

دلالة الفروق الإحصائية لاستجابات عينة الدراسة على الاستبانة تبعا للمشاركة في الجلسات.

المتغير	المشاركة	العدد	المتوسط	الانحراف المعياري	قيمة "ت"	مستوى الدلالة
بعد (الدعم النفس).	مشارك	٢٩	١٩,٤٨	٢,٦١	٢,٨٩	دالة عند ٠,٠١
	غير مشارك	٢٧	١٦,٧٤	٤,٢٣		
بعد (التكيف الاجتماعي).	مشارك	٢٩	١٨,٢٤	٢,٣٨	٢,٩٤	دالة عند ٠,٠١
	غير مشارك	٢٧	١٥,٧٧	٣,٧٦		

من الجدول السابق يتضح وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى (٠,٠١) بين متوسطي

درجات عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي على بعد: (الدعم النفسي) وبعد: (التكيف

الاجتماعي) في اتجاه: (المريضات المشاركات في جلسات الدعم النفسي).

خامساً-الإجابة على السؤال الخامس:

هل يختلف الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي لدى المتزوجات ذوات سرطان الثدي تبعاً

لنوع العلاج الحالي (كيميائي - إشعاعي - جراحي)؟

وللتحقق من وجود دلالات إحصائية لاستجابات أفراد عينة الدراسة من مريضات سرطان

الثدي على الاستبانة، فقد تم استخدام تحليل التباين الأحادي (One Way Anova)، كما

يوضحه الجدول الآتي.

جدول (٨)

نتائج تحليل التباين الأحادي لبعدي الاستبانة وفقاً لنوع العلاج.

المتغير	مصدر التباين	درجات الحرية	مجموع المربعات	متوسط المربعات	قيمة ف	مستوى الدلالة
بعد (الدعم النفسي).	بين المجموعات	٢	٧,١٣	٣,٥٦	٠,٢٥	غير دالة
	داخل المجموعات	٥٣	٧٥٤,٤٢	١٤,٢٣		
	المجموع الكلي	٥٥	٧٦١,٥٥			
بعد (التكيف الاجتماعي).	بين المجموعات	٢	١٤,٢٥	٧,١٢	٠,٦٣١	غير دالة
	داخل المجموعات	٥٣	٥٩٨,٥٨	١١,٢٩		
	المجموع الكلي	٥٥	٦١٢,٨٤			

من الجدول السابق يتضح عدم وجود فرق دال إحصائياً بين متوسطي استجابات أفراد

عينة الدراسة من مريضات سرطان الثدي وفقاً لمتغير نوع العلاج الحالي: (كيميائي - إشعاعي - جراحي).

سادسًا-الإجابة على السؤال السادس:

« ما دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي

لدى المتزوجات؟ ».

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل الانحدار الخطي البسيط (Liner Re-

gression) حيث التكيف الاجتماعي كمتغير تابع، والدعم النفسي متغير مستقل (منبئ)، وجدول

(٩) يوضح ذلك.

جدول (٩)

نتائج تحليل الانحدار الخطي البسيط.

المتغير المفسر	المتغير التابع	قيمة R	التباين المشترك R2 (نسبة إسهام جميع المتغيرات)	معامل الانحدار B	قيمة F	قيمة "ت"،	قيمة الثابت
الدعم النفسي	التكيف الاجتماعي	٠,٦٨٦	٠,٤٧	٠,٦١٥	٤٧,٩٥	**٦,٩٢	٥,٨٨

يتضح من جدول (٩) أن الدعم النفسي يلعب دور في التكيف الاجتماعي لدى مريضات

سرطان الثدي، وقد بلغت قيمة الارتباط (النموذج التنبؤي) ($R=0.686$)، كما بلغت قيمة (ف)

لدلالة الانحدار ($F=47.95$) وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى (0.01).

والنموذج التنبؤي قد أحدث تباينًا مفسرًا مقداره ($R^2= 0.47$) وهذا يعني أن (47%) من

التباين في مستوى التكيف الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي يفسره نموذج الانحدار

للمتغير المستقل الدعم النفسي (النموذج التنبؤي)، ومن ثم يمكن التنبؤ بالتكيف الاجتماعي من

خلال النموذج التنبؤي باستخدام المعادلة الآتية:

المتغير التابع = قيمة الثابت + معامل الانحدار (١) × المتغير المستقل (١) + خطأ التنبؤ.

التكيف الاجتماعي = $0.615 + 0.88$ (الدعم النفسي) + خطأ التنبؤ.

وفي ضوء هذه المعادلة يمكن القول: إن زيادة تقديم جلسات الدعم النفسي يساعد في

التكيف الاجتماعي لدى مريضات سرطان الثدي.

النموذج المفاهيمي المقترح للدراسة.

يمكن تلخيص الإطار المفاهيمي في النموذج التالي:-

أ) الدعم النفسي (العاطفي - المعرفي - السلوكي).

ب) المتغيرات الوسيطة: الصمود النفسي، الوعي الثقافي، الدعم الأسري والمؤسسي.

ج) التكيف الاجتماعي (الأسري - العام - النفسي الداخلي).

ويُفترض في هذا النموذج أن الدعم النفسي يُؤثر مباشرةً وغير مباشرة في تحقيق التكيف الاجتماعي للمريضات المتزوجات المصابات بسرطان الثدي، من خلال تفعيل آليات الصمود، وتعزيز الروابط الأسرية، وتوفير بيئة ثقافية ومؤسسية داعمة. ويُعدّ هذا النموذج أحد الإسهامات النظرية للدراسة الحالية في توطيد العلاقة بين الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي داخل السياق العربي والمصري تحديدًا. التوصيات والمقترحات.

أولاً: التوصيات الموجهة للممارسين (صناع القرار والمسؤولين).

1. دمج برامج الدعم النفسي في الخطط العلاجية الأساسية لمرضى السرطان في المستشفيات العامة والخاصة، بحيث تصبح جزءًا إلزاميًا من منظومة الرعاية الصحية، لا مجرد نشاط تكميلي.
2. تدريب الكوادر الطبية والتمريضية على مهارات التواصل النفسي والإنساني مع المريضات، بما يحقق بيئة علاجية آمنة وداعمة.
3. توسيع نطاق خدمات الدعم الأسري والاجتماعي في المؤسسات الطبية من خلال إنشاء وحدات استشارية مخصصة للأزواج والأسر، لتوجيههم حول كيفية التعامل النفسي والاجتماعي مع المريضة.

4. تعزيز دور المؤسسات الإعلامية في نشر الوعي المجتمعي حول أهمية الدعم النفسي،

والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بمرض السرطان.

5. تفعيل الشراكة بين وزارة الصحة والجمعيات الأهلية في دعم برامج التأهيل النفسي

والاجتماعي للمريضات، خصوصًا في المناطق الريفية ذات الموارد المحدودة.

6. الاستفادة من تجربة مستشفى بهية كنموذج وطني في تصميم برامج الدعم النفسي

الجماعي، وتعميم التجربة في مراكز الأورام الأخرى في مصر والعالم العربي.

7. إدماج برامج العلاج بالفن والعمل التطوعي ضمن أنشطة المستشفيات النفسية

والاجتماعية، لما لها من أثر ملموس في رفع المعنويات وتعزيز التكيف الاجتماعي.

8. تخصيص موارد مالية مستقلة في ميزانية المستشفيات لدعم الأنشطة النفسية والاجتماعية،

مع متابعة دورية لنتائجها وتأثيرها على جودة حياة المريضات.

9. تشجيع المبادرات المجتمعية والشخصيات العامة على تبني حملات توعية حول الدعم

النفسي لمرضى السرطان من منظور إنساني وثقافي.

10. وضع دليل إرشادي وطني موحد لبرامج الدعم النفسي والاجتماعي، يتضمن معايير

التدريب، والإشراف، وقياس الأثر النفسي والاجتماعي للمريضات.

ثانيًا: المقترحات الموجهة للبحوث المستقبلية.

1. إجراء دراسات مقارنة بين مريضات سرطان الثدي وغيرهن من مرضى الأورام لمعرفة

الفروق في طبيعة التكيف الاجتماعي والدعم النفسي المطلوب.

2. دراسة تأثير البرامج الإلكترونية والمجموعات الافتراضية للدعم النفسي (عبر الإنترنت) على تحسين التكيف الاجتماعي للمريضات في المحافظات البعيدة.
3. التوسع في البحوث التي تدمج التحليل الكيفي والكمّي لفهم التجارب الذاتية للمريضات بعمق أكبر، إلى جانب التحليل الإحصائي للعلاقات.
4. تصميم دراسات تتناول دور الأزواج في دعم المريضات وتأثير ذلك على جودة الحياة والتكيف الأسري بعد التشخيص.
5. اقتراح نماذج تدخل نفسي عربية مستمدة من البيئة الثقافية المصرية والعربية، بدلاً من الاعتماد الكامل على النماذج الغربية في العلاج النفسي للسرطان.
6. دراسة أثر الدعم الديني والروحي في تعزيز الصمود النفسي والتوازن الاجتماعي لدى المريضات، من منظور علم النفس الإيجابي.
7. تقييم فعالية برامج مستشفى بهية من خلال دراسات تجريبية طويلة المدى، لقياس مدى استدامة أثر الدعم النفسي بعد انتهاء فترة العلاج.
8. تحليل العلاقة بين مستوى الوعي المجتمعي بالسرطان ومدى استعداد المجتمع لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمريضات.
9. دراسة الفروق بين الفئات العمرية للمريضات في استراتيجيات التكيف وأساليب الدعم المفضلة.
10. بناء أدلة قياس عربية مقننة لقياس أبعاد الدعم النفسي والتكيف الاجتماعي، قابلة للتطبيق في البيئات العربية المختلفة.

المراجع.

١. ابن منظور. (٢٠٠٣). لسان العرب (ج ٣، ص ٤١٢-٤١٣). بيروت: دار صادر.
٢. أشنتية، عماد عبد اللطيف حسين. (٢٠١٨). تأثير المساندة الاجتماعية في الصلابة النفسية لدى المصابين بمرض السرطان. مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية، العدد ٤٦، ص ٥٥-٧٨.
٣. بوتى، شهرزاد. (٢٠٢٠). رؤية نظرية في جودة الحياة والتنمية المستدامة: الأبعاد والتحديات. أعمال الملتقى الوطني الأول، جامعة باتنة، ص ١٥-٣٢.
٤. تومي، سامية. (٢٠١٧). جودة الحياة الأسرية والدعم الاجتماعي المُدرك لدى مرضى السرطان من منظور علم النفس الإيجابي. مجلة الدراسات الإنسانية والاجتماعية، جامعة باتنة، العدد ٢، ص ١١٩-١٤٠.
٥. الحبيشي، ابتسام محمد. (٢٠٢٠). الدعم الاجتماعي الأسري لدى مريضات سرطان الثدي وعلاقته بجودة الحياة النفسية. مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة تعز، المجلد ١٢، العدد ٣، ص ٨٨-١٠٧.
٦. خالد، ريمان عيد محمود. (٢٠٢٥). الدعم الاجتماعي المُدرك وتحسين جودة الحياة: بحث ميداني على عينة من مريضات سرطان الثدي. المجلة العلمية لكلية الآداب، جامعة دمياط، المجلد ١٤، العدد ٢، ص ٣٣-١٠١.

٧. الشريف، نهى محمد. (٢٠١٩). الدعم النفسي والاجتماعي لمرضى السرطان (ص

٢٨-٢١). القاهرة: دار الفكر العربي.

٨. عبد الغفار، أحمد. (٢٠٢٠). الصحة النفسية والتكيف الاجتماعي (ص ٤٤-٥٠).

الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.

٩. العنزي، غزاي سالم. (٢٠٢٣). جودة الحياة وأنواع الدعم الاجتماعي والأبعاد المفسرة

لها لدى مريضات السرطان. مجلة مستقبل العلوم الاجتماعية، المجلد ١٥، العدد ١،

ص ٢٢-٤٤.

١٠. القرني، محمد بن علي. (٢٠١٧). الأسرة والزواج في المجتمع العربي المعاصر

(ص ١٩-٢٢). الرياض: دار الزهراء للنشر.

١١. الزهراني، عبدالله بن احمد (٢٠٢٣). الكرب النفسي والدعم الاجتماعي لدى مريضات

سرطان الثدي في ضوء بعض المتغيرات. مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر. المجلد

٣٦، العدد ١٧٥، الجزء الأول، ص ٣٢٣-٣٦٠.

١٢. مجمع اللغة العربية. (٢٠٠٤). المعجم الوسيط (الطبعة الرابعة، ص ١١١، ٤١٢،

٥٢٣، ٨٨٢). القاهرة: مجمع اللغة العربية.

١٣. مجمع اللغة العربية. (٢٠٠٤). المعجم الوسيط. القاهرة: مجمع اللغة العربية.

١٤. منظمة الصحة العالمية. (٢٠٢٣). سرطان الثدي: البيانات والتقارير العالمية (ص

٥-٣). جنيف: المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

١٥. موقع مستشفى بهية الرسمي. (٢٠٢٥). عن المستشفى (ص ١-٢). تم الاسترجاع

من <https://www.baheya.org>

٦١. Masten, A. S. (2014). Ordinary magic: Resilience in development.

New York.

17. American Cancer Society. (2024). Breast cancer overview (pp. 5-7). Atlanta, GA: ACS Press. Retrieved from <https://www.cancer.org>

18. Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. Psychological Bulletin, 98(2), 310-357.

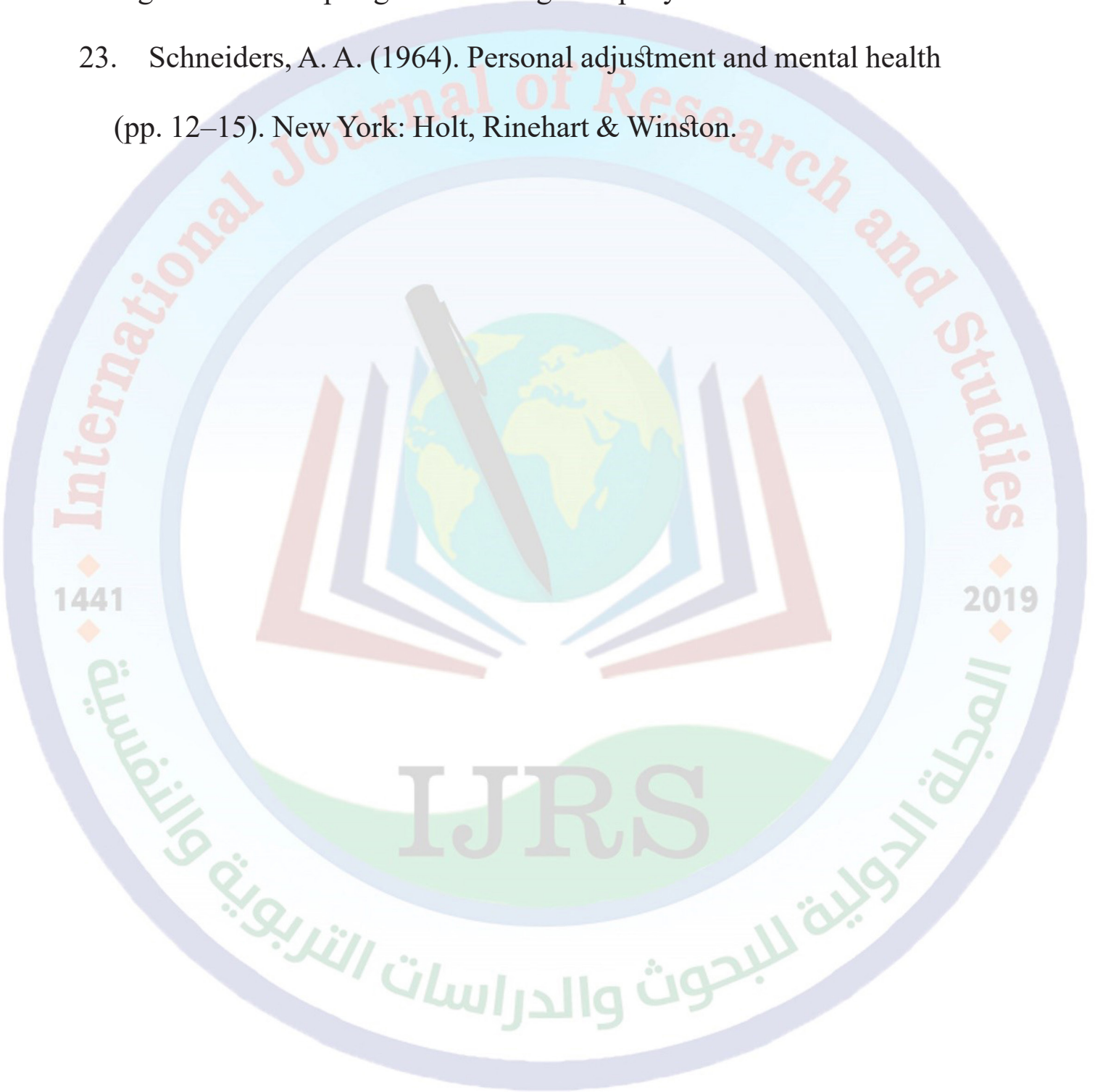
19. Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18(2), 76-82.

20. Lakey, B., & Cohen, S. (2000). Social support theory and measurement. In S. Cohen, L. Underwood, & B. Gottlieb (Eds.), Social support measurement and intervention (pp. 29-52). New York: Oxford University Press.

21. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping (pp. 62-68). New York: Springer Publishing.

22. Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Publishing Company.

23. Schneiders, A. A. (1964). Personal adjustment and mental health (pp. 12–15). New York: Holt, Rinehart & Winston.



استبانة بحثية.

بعنوان: «دور الدعم النفسي في تحقيق التكيف الاجتماعي لمواجهة تحديات سرطان الثدي لدى المتزوجات (مستشفى بهية نموذجًا)».

الغرض من الاستبانة: تهدف هذه الاستبانة إلى التعرف على مدى تأثير الدعم النفسي الذي تقدمه الأسرة والمجتمع والمؤسسات العلاجية على قدرة المريضات المتزوجات المصابات بسرطان الثدي على التكيف الاجتماعي.

ملاحظة: جميع المعلومات الواردة في هذه الاستبانة تُعامل بسرية تامة، وتُستخدم فقط لأغراض البحث العلمي.

القسم الأول: البيانات العامة.

(يرجى وضع علامة ✓ أمام الإجابة المناسبة).

م	البيان	الفئات
1	العمر	☐ أقل من ٣٠ ☐ ٣٠-٣٩ ☐ ٤٠-٤٩ ☐ ٥٠ فأكثر
2	الحالة التعليمية	☐ أقل من جامعي ☐ جامعي ☐ دراسات عليا
3	مدة الإصابة	☐ أقل من سنة ☐ ١-٣ سنوات ☐ أكثر من ٣ سنوات
4	نوع العلاج الحالي	☐ كيميائي ☐ إشعاعي ☐ جراحي ☐ متابعة
5	هل شاركت في جلسات دعم نفسي؟	☐ نعم ☐ لا

القسم الثاني: فقرات الدراسة.

ضعي علامة (✓) أمام الخيار الذي يعبر عن رأيك في كل عبارة: (١ = لا أوافق بشدة، ٢ = لا أوافق، ٣ = محايدة، ٤ = أوافق، ٥ = أوافق بشدة).

م	العبارة	1	2	3	4	5
أولاً: الدعم النفسي.						
1	أشعر أن أسرتي تمنحني المساندة والتشجيع في رحلة العلاج.	☐	☐	☐	☐	☐
2	أتلقي من الأطباء والأخصائيين النفسيين كلمات تبعث الأمل والاطمئنان.	☐	☐	☐	☐	☐
3	يخفف الدعم من شعوري بالخوف والقلق المرتبط بالمرض.	☐	☐	☐	☐	☐
4	أشعر بقبول الآخرين وتفهمهم لظروفي الصحية.	☐	☐	☐	☐	☐
5	جلسات الدعم النفسي في المستشفى تساعدني على التفكير بإيجابية.	☐	☐	☐	☐	☐
ثانياً: التكيف الاجتماعي.						
6	أحرص على التواصل مع زوجي وأفراد أسرتي رغم العلاج.	☐	☐	☐	☐	☐
7	أستطيع التعامل مع المجتمع دون خجل من إصابتي.	☐	☐	☐	☐	☐
8	أشارك في بعض الأنشطة الاجتماعية أو التطوعية.	☐	☐	☐	☐	☐
9	أواجه صعوبات الحياة بثقة وتفان.	☐	☐	☐	☐	☐
10	أشعر بالرضا عن نفسي وقدرتي على التعايش مع المرض.	☐	☐	☐	☐	☐



International Journal of Educational and Psychological Research and Studies (IJRS)

The Online ISSN : (2735-5063).
The print ISSN : (2735-5055).